

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU - CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE FRONTEIRA - MESTRADO

ELYABE RODRIGUES

Vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros: da internação à continuidade do cuidado em saúde

**FOZ DO IGUAÇU
2026**

ELYABE RODRIGUES

Vivências dos genitores de prematuros: da internação à continuidade do cuidado em saúde

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira - Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Área de concentração: Saúde Pública em Região de Fronteira

Orientador: Dr. Sebastião Caldeira

**FOZ DO IGUAÇU
2026**

FICHA CATALOGRÁFICA:

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Rodrigues, Elyabe

Vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros: da internação à continuidade do cuidado em saúde / Elyabe Rodrigues; orientador Sebastião Caldeira. -- Foz do Iguaçu, 2026.

102 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, 2026.

1. Recém-nascido prematuro. 2. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 3. Continuidade do cuidado. 4. Fenomenologia Social.. I. Caldeira, Sebastião, orient. II. Título.

RODRIGUES, E. **Vivências dos genitores de prematuros: Da internação à continuidade do cuidado em saúde.** 102 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Orientador: (Sebastião Caldeira). Foz do Iguaçu, 2026. ELYABE RODRIGUES.

Aprovado em 27/02/2026

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
 **SEBASTIAO CALDEIRA**
Data: 14/03/2026 08:00:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Sebastião Caldeira
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste

Documento assinado digitalmente
 **HELDER FERREIRA**
Data: 16/03/2026 11:29:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Helder Ferreira
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste

Documento assinado digitalmente
 **MONICA AUGUSTA MOMBELLI**
Data: 16/03/2026 10:56:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dra. Monica Augusta Mombelli
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, razão maior da minha fé, fonte de força, sabedoria e sustento em todos os momentos desta caminhada. Sou grato por Sua graça, direção e cuidado constante, que me permitiram perseverar mesmo diante dos desafios, renovando minhas forças e dando sentido a cada etapa vivenciada.

À minha esposa, Daiane, companheira fiel e indispensável, pelo amor, paciência, incentivo e compreensão ao longo de todo o percurso do mestrado. Seu apoio incondicional, suas palavras de ânimo e sua presença constante foram fundamentais para que este sonho se tornasse realidade.

Aos meus pais, Eliseu e Elizama, por todo o amor, dedicação e ensinamentos que moldaram minha trajetória pessoal, humana e acadêmica. Sou profundamente grato pelo apoio, pelas orações e por acreditarem em mim desde sempre.

À minha família; irmão, sobrinha, cunhadas, cunhados, sogros, sobrinhos e aos amigos, que, de diferentes formas, estiveram presentes, oferecendo apoio, incentivo e compreensão nos momentos de ausência e dedicação aos estudos. Cada gesto de carinho e cada palavra de encorajamento foram essenciais nessa caminhada.

Ao meu orientador, Dr. Sebastião Caldeira, pela orientação competente, ética e sensível, pela disponibilidade, paciência e contribuições valiosas ao longo do desenvolvimento desta dissertação. Sua experiência, rigor científico e compromisso com a formação acadêmica foram fundamentais para a construção deste trabalho.

À Banca Examinadora, composta pelo Prof. Dr. Helder e pela Prof.^a Dra. Mônica, meus sinceros agradecimentos pela disponibilidade, atenção e contribuições qualificadas durante a avaliação desta dissertação. A presença de ambos na banca foi de grande relevância para o aprimoramento deste trabalho e para este momento tão significativo da minha trajetória acadêmica. De modo especial, agradeço à Prof.^a Dra. Mônica, figura de suma importância em minha caminhada acadêmica e profissional, cujo compromisso com a formação, sensibilidade e dedicação constituem referência e inspiração constantes.

Aos meus colegas e amigos Nandra, Chayani e Carina, da UDC, pela convivência, parceria e apoio ao longo dessa trajetória. A vivência institucional compartilhada, marcada pela troca de conhecimentos, pelo incentivo constante e pela amizade sincera, tornou o percurso acadêmico mais leve e significativo. Cada conversa, gesto de apoio e palavra de encorajamento foram fundamentais para a concretização deste trabalho.

Com especial carinho e profunda admiração, agradeço à equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Itamed, com a qual tive a honra de trabalhar entre 2020 e 2025. Mais do que colegas de trabalho, encontrei pessoas que se tornaram amigas, cuja dedicação, sensibilidade e compromisso ético com o cuidado marcaram profundamente minha trajetória. O afeto, a escuta e a humanidade presentes no cuidado diário aos recém-nascidos e às suas famílias fizeram dessa convivência uma experiência transformadora. Estendo meus agradecimentos aos demais colegas do Hospital Itamed que estiveram comigo em algum momento, com destaque as minhas amigas Bárbara e Daniele, e aos pacientes e famílias que confiaram em meu trabalho. A convivência com todos fortaleceu valores humanos que levarei para toda a vida.

Por fim, agradeço ao Centro de Nutrição Infantil (CENNI), local de realização da coleta de dados desta pesquisa, pela oportunidade concedida e pela receptividade com que fui acolhido. Destaco a simpatia, a gentileza e a disponibilidade de toda a equipe, que abriu suas portas e contribuiu de maneira fundamental para a viabilização deste estudo. Registro meu reconhecimento, de modo particular, à enfermeira Rosicler, cuja sensibilidade, colaboração e empenho na intermediação desse vínculo foram essenciais para a realização da pesquisa.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste estudo, minha sincera gratidão.

Os milagres estão frequentemente disfarçados de prematuros
(Campanha Novembro Roxo – Hospital Itamed, 2022).

RODRIGUES, E. **Vivências dos genitores de prematuros: Da internação à continuidade do cuidado em saúde.** 102 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Orientador: (Sebastião Caldeira). Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMO

A prematuridade constitui um evento crítico que impacta significativamente a vivência de genitores, especialmente quando envolve a internação do recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a necessidade de continuidade do cuidado após a alta hospitalar. Esta pesquisa teve como objetivo compreender a vivência de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em UTIN e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e delineamento transversal, fundamentado na Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Participaram da pesquisa treze genitores de recém-nascidos prematuros residentes na região de fronteira, que vivenciaram a hospitalização do filho em UTIN no município e realizavam o seguimento do cuidado especializado no Centro de Nutrição Infantil (CENNI). A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas presencialmente entre abril e junho de 2025. As entrevistas foram gravadas, transcritas manualmente e analisadas seguindo os pressupostos da Fenomenologia Social, com leitura exaustiva dos relatos, identificação dos aspectos significativos, construção das categorias do concreto vivido, análise dos “motivos porque” e “motivos para” e tipificação do grupo social estudado. Os resultados evidenciaram que a vivência da prematuridade foi marcada por intenso sofrimento emocional, alterações na rotina de vida e ruptura das idealizações gestacionais. As estratégias de enfrentamento mobilizadas pelos genitores incluíram o apoio familiar, a fé, a troca de experiências e o vínculo com a equipe de saúde. As práticas profissionais, quando pautadas no acolhimento, na comunicação e na escuta empática, exerceram influência positiva no enfrentamento da hospitalização e na continuidade do cuidado. O seguimento ambulatorial foi compreendido como importante rede de apoio, especialmente no contexto de fronteira. A compreensão das vivências dos genitores contribui para o fortalecimento de práticas de cuidado humanizado, para a qualificação da assistência neonatal e para o desenvolvimento de políticas públicas sensíveis às especificidades das regiões de fronteira.

Palavras-Chave: Saúde na fronteira; Recém-nascido prematuro; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Genitores; Continuidade do cuidado; Fenomenologia Social.

RODRIGUES, E. **Experiences of Parents of Preterm Infants: From Hospitalization to Continuity of Health Care.** 102 p. Dissertation (Master's Degree in Public Health in a Border Region) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Advisor: (Sebastião Caldeira). Foz do Iguaçu, 2026.

ABSTRACT

Prematurity is a critical event that significantly affects parents' experiences, particularly when it involves the hospitalization of the newborn in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and the need to continue care after hospital discharge. This study aimed to understand the experiences of parents of preterm newborns during the period between hospitalization in the NICU and the continuity of health care in a border region. This is a qualitative study with an exploratory and cross-sectional design, grounded in Alfred Schütz's Social Phenomenology. The study included thirteen parents of preterm newborns living in the border region who experienced their child's hospitalization in a NICU in the municipality and were receiving specialized follow-up care at the Child Nutrition Center (CENNI). Data were collected through semi-structured interviews conducted in person between April and June 2025. The interviews were recorded, manually transcribed, and analyzed according to the assumptions of Social Phenomenology, through exhaustive reading of the reports, identification of significant aspects, construction of categories of the lived experience, analysis of the "reasons why" and the "reasons for," and typification of the social group studied. The findings showed that the experience of prematurity was marked by intense emotional distress, changes in daily routines, and the disruption of expectations related to pregnancy. Coping strategies mobilized by parents included family support, faith, the sharing of experiences, and the relationship established with the health care team. Professional practices grounded in welcoming attitudes, clear communication, and empathetic listening had a positive influence on coping with hospitalization and on the continuity of care. Outpatient follow-up was understood as an important support network, particularly in the border context. Understanding parents' experiences contributes to strengthening humanized care practices, improving the quality of neonatal care, and supporting the development of public policies sensitive to the specificities of border regions.

Descriptors: Border health; Preterm newborn; Neonatal Intensive Care Unit; Parents; Continuity of care; Social Phenomenology.

RODRIGUES, E. **Vivencias de los progenitores de recién nacidos prematuros: de la hospitalización a la continuidad del cuidado en salud.** 102 h. Disertación (Maestría en Salud Pública en Región de Frontera) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Director: (Sebastião Caldeira). Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMEN

La prematuridad constituye un evento crítico que impacta significativamente la vivencia de los progenitores, especialmente cuando implica la hospitalización del recién nacido en una Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) y la necesidad de continuidad del cuidado después del alta hospitalaria. Esta investigación tuvo como objetivo comprender la vivencia de progenitores de recién nacidos prematuros entre la hospitalización en la UTIN y la continuidad del cuidado en salud en una región de frontera. Se trata de un estudio cualitativo, de carácter exploratorio y de diseño transversal, fundamentado en la Fenomenología Social de Alfred Schütz. Participaron en la investigación trece progenitores de recién nacidos prematuros residentes en la región de frontera, quienes experimentaron la hospitalización de su hijo en la UTIN del municipio y realizaban el seguimiento del cuidado especializado en el Centro de Nutrición Infantil (CENNI). La recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas, realizadas de forma presencial entre abril y junio de 2025. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas manualmente y analizadas siguiendo los supuestos de la Fenomenología Social, con lectura exhaustiva de los relatos, identificación de los aspectos significativos, construcción de las categorías de lo concreto vivido, análisis de los “motivos porque” y “motivos para”, y tipificación del grupo social estudiado. Los resultados evidenciaron que la vivencia de la prematuridad estuvo marcada por intenso sufrimiento emocional, cambios en la rutina de vida y ruptura de las idealizaciones gestacionales. Las estrategias de afrontamiento movilizadas por los progenitores incluyeron el apoyo familiar, la fe, el intercambio de experiencias y el vínculo con el equipo de salud. Las prácticas profesionales, cuando estuvieron basadas en la acogida, la comunicación y la escucha empática, ejercieron una influencia positiva en el afrontamiento de la hospitalización y en la continuidad del cuidado. El seguimiento ambulatorio fue comprendido como una importante red de apoyo, especialmente en el contexto de frontera. La comprensión de las vivencias de los progenitores contribuye al fortalecimiento de prácticas de cuidado humanizado, a la cualificación de la atención neonatal y al desarrollo de políticas públicas sensibles a las especificidades de las regiones de frontera.

Palabras clave: Salud en la frontera; Recién nacido prematuro; Unidad de Terapia Intensiva Neonatal; Progenitores; Continuidad del cuidado; Fenomenología Social.

LISTA DE SIGLAS

APS	Atenção Primária a Saúde
BP	Baixo Peso
CENNI	Centro de Nutrição Infantil
CMI	Centro Materno Infantil
EBP	Extremo Baixo Peso
ESF	Estratégia Saúde da Família
EUA	Estados Unidos da América
IG	Idade Gestacional
MBP	Muito Baixo Peso
MS	Ministério da Saúde
ONG	Organização não Governamental
PC	Paralisia Cerebral
RC	Rede Cegonha
RN	Recém-Nascido
RNPT	Recém-Nascido Pré-Termo
SIS	Fronteiras - Sistemas Integrados de Saúde das Fronteiras
SP	São Paulo
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UCIN	Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal
UNIOESTE	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
UTIN	Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
UTI-Neo	Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos genitores.	61
Tabela 2 - Informações dos prematuros.	62

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 OBJETIVOS	17
3 QUADRO TEÓRICO	18
3.1 A FENOMENOLOGIA SOCIAL DE ALFRED SCHÜTZ.....	18
3.2 O MATERNAR E A IDEALIZAÇÃO DO BEBÊ	20
3.3 DA PREMATURIDADE A INTERNAÇÃO EM UTI.....	22
3.4 DA ALTA A CONTINUIDADE DO CUIDADO AO PREMATURO EM REGIÃO DE FRONTEIRA	25
4 PERCURSO METODOLÓGICO	30
4.1 TIPO DE ESTUDO	30
4.2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO	30
4.3 CENÁRIO DA PESQUISA	30
4.4 POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DO ESTUDO	32
4.5 COLETA DE DADOS	32
4.6 ANÁLISE DOS DADOS	34
4.7 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA.....	35
4.8 PROCEDIMENTOS ÉTICOS.....	36
5 RESULTADOS	38
5.1 ARTIGO 1.....	39
5.2 ARTIGO 2.....	55
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	81
REFERÊNCIAS:	83
APÊNDICES	90
ANEXO.....	100

1 INTRODUÇÃO

A gravidez é um processo permeado por diversos sentimentos e emoções, no qual os relacionamentos e as identidades construídas ao longo da vida são ressignificados frente ao desejo e à possibilidade dessa nova realidade que se interpõe. Comumente, os pais vivenciam a intensa elaboração de planejamentos, fantasias e expectativas acerca do que está por vir, idealizando e aguardando o nascimento de um filho saudável, capaz de perpetuar valores e características familiares (Castro; Germano; Ferreira, 2019). No entanto, o planejamento familiar nem sempre se concretiza, uma vez que, em determinadas situações, a interrupção da gestação configura-se como uma medida terapêutica necessária para resguardar a vida da criança e da mãe.

Nesse contexto, a prematuridade resulta em condições clínicas desfavoráveis à manutenção da vida no ambiente extrauterino, considerando que os sistemas e órgãos do recém-nascido ainda se encontram imaturos (Neves; Ravelli; Lemos, 2010). De acordo com dados da *World Health Organization* e do *United Nations Children's Fund* (2018), nascem, anualmente, cerca de trinta milhões de bebês prematuros em todo o mundo. O Brasil figura entre os dez países com os maiores índices de prematuridade, apresentando uma prevalência aproximada de 11,7% em relação ao total de partos registrados, percentual semelhante ao observado em países de baixa renda, o que evidencia a prematuridade como um relevante problema de saúde pública (Brasil, 2021).

Quando ocorrem intercorrências durante a gestação que levam ao nascimento antecipado da criança e à consequente internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), os genitores experimentam intenso sofrimento emocional, associado a sentimentos de medo, angústia e insegurança. Esses sentimentos decorrem tanto das mudanças repentinas na dinâmica e organização familiar quanto da preocupação com a recuperação do recém-nascido e da desconstrução das idealizações previamente elaboradas (Zanfolim; Cerchiari; Ganassin, 2018).

Ademais, o ambiente hospitalar, especialmente o da UTIN, impõe limites aos genitores, exigindo reorganização subjetiva diante de um espaço desconhecido, marcado por tecnologias, ruídos, iluminação intensa e procedimentos invasivos (Cruz Dantas *et al.*, 2015).

Quando o tratamento em UTIN é bem-sucedido e o prematuro alcança a recuperação esperada, o cuidado não se encerra com a alta hospitalar. O recém-nascido continuará sendo acompanhado após a alta médica, no mínimo, até os 24 meses de vida. A alta do bebê da

UTIN para o domicílio demanda da família cuidados específicos ao recém-nascido pré-termo, uma vez que os pais passam a assumir a atenção domiciliar, ainda que frequentemente não se considerem preparados para tal responsabilidade (Brassarola; Natarelli; Fonseca, 2023). Diante dos medos e anseios vivenciados, destaca-se a importância da preparação da família para os cuidados desde a internação até o período pós-alta, com ênfase no papel educativo da equipe de enfermagem.

O município de Foz do Iguaçu, onde foi realizada a coleta de dados, integra a 9ª Regional de Saúde do Paraná e constitui referência no atendimento à gestação de alto risco e à neonatologia. Destaca-se que muitos genitores de recém-nascidos prematuros não residem no município e, em alguns casos, sequer no país, necessitando deslocar-se por meio de transporte social ou recursos próprios para acompanhar o tratamento na UTIN e, posteriormente, dar seguimento ao cuidado ambulatorial no Centro de Nutrição Infantil (CENNI) (Hirano *et al.*, 2023).

Nesse cenário, torna-se fundamental refletir sobre o papel exercido pela equipe de saúde que presta assistência aos recém-nascidos e às suas famílias. O preparo profissional e a educação permanente configuram-se como estratégias essenciais para a efetivação do cuidado humanizado, contribuindo para o desenvolvimento de competências relacionadas à comunicação de notícias difíceis, ao acolhimento e à escuta empática, compreendidas como tecnologias leves do cuidado (Seixas *et al.*, 2021). O seguimento da assistência ao recém-nascido pré-termo ocorre na Atenção Primária à Saúde (APS) e em ambulatórios especializados, exigindo dos genitores participação ativa, disponibilidade de tempo e envolvimento contínuo no cuidado.

Segundo dados da Plataforma Integrada da Vigilância do Ministério da Saúde, somente no ano de 2025 foram registrados 476 nascidos vivos prematuros, com menos de 37 semanas de gestação, na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu (Brasil, 2025), a qual abrange, além do município sede, diversas cidades do oeste paranaense. Por se tratar de uma região fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, observa-se a presença significativa de estrangeiros não residentes que acessam o Sistema Único de Saúde em busca de acompanhamento especializado, seja pela gratuidade, pela qualidade da assistência ou pela proximidade geográfica (Hortelan *et al.*, 2019).

Ressalta-se que o Brasil possui uma extensa faixa de fronteira, regulamentada pela Constituição Federal, correspondente a uma linha de 150 km de largura, abrangendo 588 municípios (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017). Segundo Giovanella *et al.* (2007), essas regiões

caracterizam-se por baixo desenvolvimento socioeconômico e por expressivas diferenças sociais, culturais e econômicas, o que favorece a intensa circulação populacional e a procura por serviços de saúde em cidades fronteiriças.

A literatura tem abordado os impactos emocionais da prematuridade e da internação em UTIN, porém ainda são escassos estudos que compreendam as vivências dos genitores ao longo de todo o percurso do cuidado, desde a hospitalização até a continuidade do acompanhamento após a alta.

Além disso, há limitada produção científica que analise esse fenômeno à luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, especialmente em regiões de fronteira. Nesse contexto, a dinâmica fronteiriça pode ampliar o fenômeno já descrito em outros estudos, ao envolver intensa mobilidade populacional, presença de usuários estrangeiros e desafios relacionados ao acesso e à continuidade do cuidado em saúde. Os resultados desta dissertação contribuem para o fortalecimento de práticas de humanização da assistência e para o aprimoramento das políticas públicas em saúde.

Este estudo teve como objetivo compreender as vivências de genitores de recém-nascidos prematuros no percurso entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e a continuidade do cuidado em saúde em uma região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

A pesquisa foi motivada pela prática profissional do autor, que atuou por mais de cinco anos em uma UTIN de um hospital de Foz do Iguaçu, pertencente à 9ª Regional de Saúde do Paraná, e como membro da equipe de Cuidados Paliativos Neonatais, acompanhando e oferecendo suporte psicológico a pais que vivenciaram a internação de um filho prematuro.

A experiência profissional do autor, possibilitou observar o elevado impacto emocional desse período, bem como as ressignificações necessárias para o enfrentamento da internação prolongada, que envolve desgaste físico e psíquico, além de outros fatores estressores que persistem durante e após a alta hospitalar. Evidenciou-se, ainda, a importância da atuação da equipe de saúde, que pode constituir-se como uma rede de apoio para os familiares que, em sua maioria, deixam seus lares e atividades laborais para acompanhar o tratamento do filho em uma região de fronteira.

2 OBJETIVOS

Geral: Compreender a vivência de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira;

Específicos: 1. Conhecer as experiências, dificuldades e alterações emocionais vivenciadas no cotidiano de vida de genitores de recém-nascidos prematuros que passaram por hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em região de fronteira, e dão seguimento do cuidado especializado no CENNI; 2. Identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos genitores de recém-nascidos prematuros que passaram por hospitalização em UTI Neonatal em região de fronteira, e mantém o seguimento do cuidado especializado no CENNI; 3. Apreender as práticas e influências da equipe de saúde neonatal no processo de cuidado ao recém-nascido prematuro, entre a hospitalização e o seguimento da assistência;

3 QUADRO TEÓRICO

3.1 A FENOMENOLOGIA SOCIAL DE ALFRED SCHÜTZ

O sociólogo Alfred Schütz nasceu em Viena, Áustria, em 1899, e faleceu em Nova Iorque, EUA (Estados Unidos da América), em 1959. Seus estudos tinham como base as ideias de Edmund Husserl e Max Weber, sendo que o primeiro propunha uma filosofia da experiência humana consciente, compreendendo que o sujeito que vive e atua no mundo, busca também interpretá-lo e fornecer-lhe um sentido. Nessa perspectiva, Husserl possibilitou que Schütz encontrasse em suas proposições o arcabouço que lhe direcionaria à compreensão da subjetividade, amparando-se no conceito de intersubjetividade. Já a influência de Weber está pautada no entendimento de que a ação do homem no mundo social só tem significação e é considerada propriamente como ação quando é direcionada ao outro, de forma intencional (Schütz, 1979).

Durante sua trajetória como sociólogo, pesquisador e escritor, Schütz publicou 33 textos, traduzidos para o inglês, alemão, francês e espanhol, sendo a primeira obra de 1932, intitulada “A construção significativa do mundo social”, onde apresentou as bases fundamentais de sua teoria, ideias herdadas de Weber e Husserl (Jesus *et al.*, 2013). Propondo-se a decifrar de forma sistemática os escritos de Husserl, Schütz buscava os princípios fenomenológicos para a Teoria da Ação de Weber. Sua análise conclui que ele não estava diante dos problemas concretos das Ciências Sociais, e que era necessário a superação destas lacunas, passando a desenvolver conceitos básicos de Husserl e transformando-os em fundamentos primordiais da teoria sociológica do mundo social (Souza, 2012).

Conforme o teórico, a relação social é o elemento fundamental para se interpretar os significados das ações dos indivíduos no mundo cotidiano. Dessa forma, quaisquer ciências que almejem interpretar a ação humana, devem partir da realidade do mundo cotidiano, que é permeado pela estrutura que permite a construção social dos sujeitos e influencia diretamente suas relações (Schütz, 2009).

Para fenomenologia social, o homem nasce em um cenário já concebido e estruturado previamente, chamado de mundo cotidiano, e a leitura que este faz desta realidade direciona-o a agir de modo natural frente a realidade social. O sujeito então, ao intervir de forma natural

neste mundo, influencia e é influenciado, moldando continuamente e modificando suas estruturas sociais, o que Schütz nomeia de atitude natural (Schütz, 2009).

Considerando que os seres humanos coexistem e interagem entre si, não só de forma biológica, mas sendo capazes de ter consciência dessas relações, o mundo é então intersubjetivo, como afirma Schütz. O conceito de intersubjetividade abrange o formato de vinculação humana nas distintas relações sociais, onde o sujeito compreende e é compreendido por elas, vivendo em um mundo cultural encharcado de significações, que precisarão ser interpretadas para orientá-lo e conduzi-lo enquanto pessoa (Schütz, 2008).

Segundo Schütz (2008), cada ser humano interpreta o mundo baseado em seus próprios interesses e desejos ideológicos, culturais e religiosos. Os sentidos atribuídos aos fenômenos da realidade estão relacionados a cultura do sujeito, porém, manifestam-se na vida individual, associando-se ao arcabouço de experiências adquiridas durante sua existência. Esse acúmulo de conhecimentos está acessível ao sujeito, conforme sua construção biográfica.

De acordo com Capalbo (2008), a consciência humana em sua existência concreta é finita e temporal, alocada em determinado meio social, momento histórico e cultural. Ela não é apenas lançada ao mundo, pois seu ser no mundo é poder tomar posição frente a esta inserção, e ter consciência dela. Neste sentido, a consciência volta-se de forma intencional para o mundo e torna-a sobre si mesma, a isto denomina-se na fenomenologia, intencionalidade de consciência.

Cada ação é interpretada pelo sujeito baseando-se em seus motivos existenciais, advindos das experiências registradas na subjetividade, formando assim as bases de direcionamento da ação no mundo. Quando o homem se relaciona buscando alcançar objetivos, metas, expectativas e projetos, denomina-se “motivos para”, e quando se fundamenta nas experiências vividas no âmbito biopsicossocial, em uma espécie de agregado de conhecimento, chama-se de “motivos porque” (Caldeira *et al.*, 2025).

A compreensão do sujeito no mundo, sob a perspectiva das ciências sociais, ocorre através da ótica subjetiva das relações. O transcender dessa compreensão exige que o pesquisador se distancie do sujeito pesquisado, para observá-lo e propor uma estratégia sistemática para compreensão subjetiva do sentido, a partir do agrupamento das informações (Jesus *et al.*, 2013). A fenomenologia social como método de pesquisa, é um caminho ou uma atitude do pesquisador para acessar e compreender a essência das coisas. O objetivo é pôr em suspensão as ideias obtidas dos eventos, para que assim, estas se mostrem conforme

a experiência original. A manifestação destes sentidos das coisas, é revelada por meio do discurso do sujeito, durante as conversas (Freitas; Moura; Monteiro, 2016).

3.2 O MATERNAR E A IDEALIZAÇÃO DO BEBÊ

A maternidade é, ainda, um tema amplamente debatido por perspectivas religiosas, socioculturais, psicológicas e míticas na atualidade, assim como habitualmente o foi no desenvolvimento histórico da humanidade (Hahn, 2022). A perspectiva analítica junguiana propõe que a figura materna sempre esteve presente no inconsciente coletivo humano, sendo este, o reservatório de traços de memória racial latente herdado do passado ancestral, resíduo do desenvolvimento evolutivo, universal. Este passado primitivo é a base da psique humana, pois dirige e influencia o comportamento presente (Jung, 1957/ 2015).

Segundo Freud (1932/ 2010), a maternidade configura-se como um destino para a feminilidade. O tornar-se mãe para algumas mulheres, equivaleria nesse sentido, ao tornar-se mulher. Essa introdução à nova identidade serviria para tamponar o vazio, a incompletude da figura feminina. Neste pensamento, o bebê pode ser entendido como o objeto fálico, que substitui e obstrui a castração da mãe.

Já para Soler (2005), pensar a maternidade como solução para o destino feminino é estreitar o leque de opções perante outras possibilidades para as quais a mulher pode direcionar seu investimento. Se até o presente século o papel de esposa e mãe era a única designação social possível para a figura feminina, atualmente este pensamento não mais se sustenta. Mesmo o desejo pela maternidade, nutrido pelo desejo simbólico do objeto fálico, pode realizar-se em outros objetos, pois a mulher dos tempos de Freud não é a mesma dos dias de hoje.

Se por um lado, algumas mulheres encontram na maternidade a felicidade e realização, como uma forma de identificação, há também aquelas que direcionam o desejo para além dos cuidados maternos, buscando por exemplo, a independência e o reconhecimento profissional. Nas últimas décadas, o desejo de gestar e ser mãe passou a ser concebido mais tardiamente, por volta dos trinta anos de idade. Esse planejamento ocorre comumente após a conclusão dos estudos, a vivência de novas experiências e maior estabilidade profissional e conjugal, o que evidencia que a feminilidade atualmente tem desmistificado os modelos culturais e sociais dos séculos passados (Badinter, 2011).

Ainda assim, conforme Hahn (2022), o lugar simbólico que a sociedade contemporânea atribui à mulher continua sendo o da família. Inclui-se no vocabulário comum, inclusive, a existência do conceito de “instinto materno”, que associa a mulher a função de mãe. Essa maternidade aparentemente opcional, é ainda hoje, o principal componente definidor da identidade feminina. Nesta concepção, a mulher ao se descobrir grávida, deve viver o amor incondicional e a felicidade imediata que esta descoberta lhe proporciona. O não desejo de tornar-se mãe é inconcebível pela perspectiva social, pois ainda se tem a concepção da maternidade romantizada e perfeita, onde o bebê é sinônimo de completude e alegria.

Ao se confirmar a gestação, as mulheres costumam apresentar sentimentos ambivalentes, que amiúde, causam conflitos intrapsíquicos, pois podem ser interpretados como rejeição ao filho, ou a própria função materna. Essa ambivalência emocional está associada à transposição subjetiva de posições; de filha para mãe. Ressalta-se nessa linha, que é necessária a elaboração de um luto pela posição infantil para que se alcance o lugar materno, partindo das identificações da infância (Ferrari; Piccinini; Lopes, 2007).

De acordo com Aragão (2007), a efetivação da representação de um bebê no psiquismo materno se constrói durante todo o período gravídico. No início, a imagem do bebê se apresenta a mulher como um estrangeiro, um enigma que ela deverá aprender a decifrar. Durante os meses subsequentes, o feto deve passar a ser objeto de projeções inconscientes que constituíram o arcabouço de experiências infantis da gestante. É nesse período gestacional, que a mulher irá tornar esse estrangeiro um familiar, atribuindo-lhe características através da projeção e da idealização, que são derivadas de sua própria história infantil.

Se o início da gestação é marcado, para mulher, pelo sentimento de ter o corpo ocupado e invadido por um ser que, mesmo quando desejado, é percebido como um intruso, ao final da gestação, através de importantes mudanças, a mãe constrói para o bebê um lugar em sua vida e em seu próprio corpo. Assim como o feto precisa de tempo para se desenvolver e constituir-se enquanto organismo, a mulher precisa desse período para se constituir como mãe, pois as experiências e mudanças de ordem fisiológica que ela sofre, não estão dissociadas de seu esboço subjetivo (Aragão, 2007).

De acordo com Lebovici (1987), este processo de construção psíquica da mulher durante a gestação propicia a elaboração da imagem do bebê através de fantasias, impressões e sentimentos direcionados a ele. Essas representações maternas em relação ao feto, serão

intensificadas no decorrer da gravidez, de acordo com os movimentos fetais, das referências verbais, da imaginação do sexo e das características do bebê e da própria função materna. Após o nascimento, as idealizações serão reconstruídas, de acordo com as características reais da criança.

Para Stern, Stern-Bruschweiler e Freeland (1999/2013), é como se na mulher, houvesse três gestações concomitantes; a primeira associada ao desenvolvimento biológico fetal no útero, a segunda referente a atitude da mulher no psiquismo materno, e a última que diz respeito à formação do bebê imaginado em sua mente. No plano biológico, ocorre a lenta transformação da célula em ser humano. Já no nível de relação com o objeto, essa célula é representada desde o começo pelo corpo imaginário, que precede e acompanha a criança. É no decorrer da gestação que a mulher processa, em nível psíquico, e se prepara para estabelecer contato e se relacionar com esse ser que está para nascer.

Esse processo de construção da imagem do bebê costuma ocorrer com maior intensidade a partir de uma fase de maior segurança da gestação, principalmente quanto aos riscos de aborto espontâneo, por volta do terceiro mês. Desse período em frente, os exames, ultrassonografias e movimentos fetais constantes influenciam na imagem imaginada referente as características físicas, e até de personalidade do filho(a), conforme as expectativas parentais. Por volta do sétimo mês de gestação, essa representação do bebê tende a estar bem definida, e a partir do oitavo e nono mês irá iniciar-se um processo de refreada ou refreamento na imaginação, visto que logo os pais encontrarão o bebê real (Lebovici, 1987).

3.3 DA PREMATURIDADE A INTERNAÇÃO EM UTI

Em alguns casos, dependendo das intercorrências vivenciadas durante a gestação, o parto pode ser antecipado, e o bebê nascer antes das trinta e sete semanas. As causas que podem levar a essa prematuridade podem ser eventos agudos ou doenças que geram riscos à vida da mãe e do bebê, como: pré-eclâmpsia, doenças crônicas, infecções, hipertensão, deslocamento de placenta, entre outras patologias (Marchetti; Moreira, 2015). Para Mathelin (1999), esse nascimento pré-termo da criança pode inclusive acarretar dificuldades para as mães descreverem com detalhes e profundidade a interação com o bebê imaginário, como consequência da privação do último período de gestação.

O prematuro é a criança que nasceu pré-termo, ou seja, em um período prévio às 37 semanas de gestação, podendo ser classificado como prematuro limítrofe aquele nascido entre 36 e 37 semanas; moderado nascido entre 31 e 36 semanas e prematuro extremo aquele nascido entre 24 e 30 semanas de idade gestacional. Trata-se de um bebê biologicamente mais vulnerável do que aquele nascido a termo (acima das 37 semanas), devido à sua imaturidade orgânica (Brasil, 2021).

Como um dos resultados mais comuns da prematuridade gestacional, os recém-nascidos (RN) podem apresentar baixo peso (BP). Consideram-se BP os bebês que nascem pesando menos de 2500g. Os RNs com peso inferior a 1500g são classificados como de “muito baixo peso” (MBP), e os que apresentam peso abaixo de 1000g, são considerados como de “extremo baixo peso” (EBP). (Esteves *et al.*, 2023). Concomitantemente, os prematuros podem apresentar patologias diversas, como a doença da membrana hialina, síndrome de aspiração meconial, anoxia neonatal, hipoglicemia, icterícia fisiológica, gastrosquise, hidrocefalia, mielomeningocele, pneumonia, entre outras (Carvalho; Pereira, 2017).

Devido à sua condição clínica, o recém-nascido prematuro necessita de cuidados especiais da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-Neo), o que pode envolver longos períodos de hospitalização, de dias, semanas ou meses. Os reflexos das internações prolongadas podem interferir diretamente no estabelecimento do vínculo entre pais e bebês, e consequentemente, afetar o desenvolvimento físico e emocional da criança. O espaço da UTI visa minimizar este impacto sofrido pelo RN ao ter saído do útero antecipadamente. Nesta unidade, a incubadora é o instrumento que permite a aproximação do RN com o período intrauterino anterior, propiciando proteção e o aquecimento necessário ao bebê, para que ele siga se desenvolvendo, à medida que é assistido pelos pais e pela equipe (Gallegos-Martinez; Reyes-Hernandez, Scochi, 2013).

Segundo Giguere e Silva (2024), a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é um local preparado para receber pacientes recém-nascidos de alto risco, com propósito de prestar assistência através de uma equipe qualificada para desempenhar o cuidado ao neonato. O objetivo é garantir maiores possibilidades de sobrevivência e reabilitação, porém, não deixa de ser visto como um ambiente hostil e amedrontador, principalmente para aqueles que ainda não se adaptaram a ele. Corroborando com essa proposição, Baseggio *et al.*, (2017) caracterizam a UTI Neo como um espaço onde as luzes são fortes e contínuas, a temperatura é controlada e os pacientes são submetidos a vários procedimentos médicos cotidianamente,

o que pode causar angústia e estranhamento nos pais, visto que ainda estão presos a imagem de um bebê imaginado, que é muito distante do bebê real, frágil e pequeno.

Para Lemos e Faria (2024), nos casos de hospitalização em UTIN, a família vivencia momentos de sofrimento, preocupação, culpa, insegurança, frustração, medo, tristeza, desapontamento, ansiedade e falta de confiança na capacidade de cuidar do filho. O estabelecimento do vínculo inicial entre pais e a criança prematura é essencial nesse ambiente, uma vez que o contato físico e a interação, através da fala, favorecem o desenvolvimento e a evolução clínica do RN. Frente a essa experiência, é de extrema importância que a instituição forneça assistência a todos os familiares envolvidos no processo de hospitalização, e não somente ao prematuro (Acosta; Cabrera, 2016).

Partindo do entendimento que de os contatos iniciais dos genitores com seu bebê prematuro, com toques envolventes, se transformam em massagens e carícias, e são fundamentais para o estabelecimento de vínculo e recuperação da saúde do RN, ressalta-se que estes devem ser estimulados e ampliados pela equipe (Andrade; Baccelli; Benincasa, 2017). A assistência voltada apenas ao diagnóstico e à terapêutica, de forma exclusiva, visando à recuperação e ao controle da doença, conduz a equipe de saúde e a instituição a se apropriarem do corpo do recém-nascido, como um sequestro. Desse modo, é preciso que além da técnica despendida e todo o esforço para manutenção da vida, a equipe forneça a recuperação de laços afetivos, proporcionando melhor qualidade de vida, mesmo quando esta seja limitada (Scochi, 2001).

Destaca-se neste contexto, a importância da adoção de tecnologias em saúde, que perpassem os processos de acolhimento, como propõe Coelho e Jorge (2009). Segundo os autores, as tecnologias podem ser leves, leve-duras e duras. As tecnologias leves são as das relações, as leve-duras se referem às teorias e saberes; e as duras aos recursos materiais. A utilização de tecnologias leves possibilita a humanização do atendimento, o gerenciamento dos processos de atenção integral, a prevenção de doenças e a promoção e recuperação da saúde, gerando laços entre os trabalhadores da saúde e os usuários.

Em contribuição à temática, Zanfolim, Cerchiari e Ganassin (2018) afirmam que, mediante aos sentimentos emergidos ou emergentes nos genitores e toda a família durante o processo de hospitalização de um recém-nascido em UTI, deve-se pensar na utilização de estratégias pelos serviços de saúde, visando à promoção da humanização no cuidado, ao acolhimento, ao apoio na reorganização e à adaptação frente à nova realidade familiar. O acolhimento prestado deve ir além da recepção dos usuários, buscando aproximá-los da

equipe assistencial, estabelecendo uma relação que envolva escuta, respeito, empatia, e a singularidade dos conhecimentos de cada envolvido.

Defendendo o uso do paradigma sistêmico para o cuidado neonatal, concebido por Bertalanffy (1968), Rezende Tavares, Mota e Magro (2006) afirmam que o modelo amplia as fronteiras disciplinares, por meio de uma visão sistêmica que se apresenta como um guia para a leitura dos fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, antropológicos e ideológicos. Nessa perspectiva, pensar sistemicamente está intrinsecamente relacionado a forma de compreender que a inclusão de familiares, além dos genitores, beneficia não apenas a criança, mas funciona como uma matriz de apoio, que inclui os próprios genitores. É lidando com a complexidade, enfatizando a interação entre os fenômenos, que esse paradigma pode favorecer a ampliação da maternagem no contexto de hospitalização.

3.4 DA ALTA A CONTINUIDADE DO CUIDADO AO PREMATURO EM REGIÃO DE FRONTEIRA

Passado o primeiro tempo de internação do prematuro, comumente envolvendo ciclos prolongados de dias, semanas ou meses em UTIN e UCIN (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal), em casos de sucesso terapêutico, os familiares precisarão se adaptarem e elaborarem a possibilidade de enfim irem para casa, onde enfrentarão novas rotinas nos cuidados, e o seguimento da assistência, tanto em ambulatorios especializados quanto na rede básica de saúde (Esteves *et al.*, 2023). Queiroz *et al.*, (2024) ressaltam que o RN pré-termo só pode ser considerado preparado para a desospitalização, quando apresenta estabilidade clínica, e quando o contexto familiar está apto e possui habilidades mínimas necessárias para prestar os cuidados no cotidiano domiciliar.

O momento de alta do recém-nascido após uma longa internação em UTI é muito aguardado e desejado pelos genitores, porém, é também um período de emoções ambivalentes, com destaque para sintomas de ansiedade, angústia, euforia, medo e criação de expectativas quanto ao futuro familiar em casa. Mediante a nova realidade que se interpõe, a mãe percebe a necessidade da integridade do cuidado do RN, e sofre com as dúvidas, sentimento de insegurança quanto aos cuidados básicos e especiais e de incapacidade, pois até o dado momento, podia contar com a responsabilidade técnica da equipe de saúde do hospital. Nesta fase, uma vez mais, a genitora deve recorrer ao amparo profissional, a fim de

reduzir os medos e angústias e adquirir maior segurança na execução dos cuidados após a desospitalização (Estevam; Silva, 2016).

Conforme Camargo *et al.*, (2023), o prematuro tem maior risco de apresentar complicações neurológicas, até 15% são diagnosticados com paralisia cerebral (PC), e cerca de 50% sofrem com alterações motoras. Em muitos casos, os déficits motores são leves e somente percebidos após a alta, durante o desenvolvimento da criança, na primeira infância. Segundo o referido autor, em sua pesquisa observacional transversal que incluiu 30 lactentes prematuros (IG<37 semanas) que passaram por internação em UTIN em três hospitais de uma cidade do estado de SP, a principal influência do baixo desempenho motor, sensorial e comportamental dos prematuros é a falta de contato e interação com os genitores, pois quando são limitados neste aspecto pelas normas e rotinas da instituição, durante a internação, os bebês podem desencadear mecanismos de estresse, insegurança, solidão e abandono.

Para Queiroz *et al.*, (2024), o desenvolvimento neurocognitivo e comportamental do RNPT pode ser comprometido devido as características mórbidas neonatais e ambientes estressores. A repercussão dessas alterações pode envolver atrasos motores, comprometimento global, problemas de percepção visual, e déficits de funcionamento executivo e na aprendizagem. Sendo assim, torna-se evidente a importância dos programas bem estruturados de seguimento de bebês pré-termos, que se iniciam ainda na internação hospitalar, e prosseguem nos ambulatórios.

Neste sentido, Xavier, Bernardino e Gaíva (2020) afirmam que mediante ao risco aumentado de sequelas neurológicas de crianças prematuras e o aumento das taxas de sobrevivência dos recém-nascidos egressos de UTIN, reforça-se a necessidade da ampliação dos cuidados para além do hospital, de forma que se estenda para os ambulatórios de saúde, atenção primária e atenção domiciliar.

Um mecanismo comumente utilizado pela rede de saúde dos municípios, são os programas de *follow-up*. O objetivo do *follow-up* é garantir o cuidado da criança após a desospitalização, contribuindo para o diagnóstico precoce e intervenções profiláticas, fornecendo suporte às famílias, esclarecendo, apoiando, facilitando vínculos e possibilitando pesquisas em prematuridade para garantir avanços nos tratamentos (Sergipe, 2020). Segundo Formiga, Silva e Linhares (2018), a integração da equipe no programa de *Follow up* proporciona o atendimento integral aos bebês e cuidadores, sendo constituído por médico pediatra, neonatologista, neurologista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo,

nutricionista, terapeuta ocupacional e assistente social. Nesta equipe, cada profissional possui suas atribuições internas do programa, e a troca de informações constantes é uma necessidade fundamental.

A partir de 2011, com o decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8.080/90 e dispõe sobre a organização do SUS, viabilizou-se aos usuários a continuidade do cuidado em saúde em distintas especialidades, serviços, hospitais e unidades, incluindo a rede de atenção materno infantil (Hirano *et al.*, 2023). Uma das estratégias do Ministério da Saúde (MS), buscando alcançar melhorias na atenção ao parto e puerpério, surgiu então, no mesmo ano, como uma das redes temáticas do SUS, com o propósito de garantir atenção humanizada no pré-natal, parto, puerpério, e atenção infantil até os 24 meses, através da Rede Cegonha (RC), que mais tarde, em 2024, seria substituída pela Rede Alyne (Santos Filho; Souza, 2020).

A Rede Alyne, implantada em setembro deste ano, é o novo programa do Governo Federal, que reestrutura a antiga Rede Cegonha na rede pública de saúde, homenageando Alyne Pimentel, que morreu grávida de seis meses por desassistência. Entre as inovações do novo programa, está o plano integrado entre a maternidade e a Saúde da Família. O objetivo é acabar com a peregrinação da gestante, garantindo vagas para o atendimento de urgência, prioritariamente para a maternidade (Brasil, 2024).

Segundo Laste *et al.*, (2024), a atenção ao RNPT deve ocorrer através de visitas domiciliares, por meio das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), tencionando aproximar os usuários e os serviços de atenção básica de saúde. Porém, nota-se que em determinadas regiões, com destaque para as regiões fronteiriças do país, os serviços de saúde enfrentam dificuldades básicas, que impedem a oferta de maior qualidade na assistência e fragmentam o plano de cuidado domiciliar do RNPT (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017).

A região de fronteira do Brasil, tem características predominantes no que diz respeito a assistência à saúde, quando comparadas a demais regiões, visto que os moradores de outros países elegem os serviços de saúde do país, como tendo maior qualidade que os da localidade de origem. Por este motivo, e ainda, pela gratuidade da assistência, os estrangeiros aderem para as regiões de fronteiras no Brasil, o que acarreta a sobrecarga dos sistemas de saúde das cidades, pois além deste público, também brasileiros residentes em outros países buscam o atendimento nestes serviços (Zaslavsky; Goulart, 2017).

Em Foz do Iguaçu, cidade de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a demanda de atendimento da população está acima dos serviços de oferta, o que causa a

deterioração da prestação do atendimento de qualidade, que objetiva promover as intervenções integradas de saúde e apoio social para continuidade do cuidado, que envolve também os recém-nascidos de risco. Além disso, a população flutuante dos municípios de região fronteiriça, tornam a assistência à saúde dispendiosa devido ao alto índice de atendimento, que é superior ao planejamento e investimento (Berres; Baggio, 2020).

Para Zaslavsky e Goulart (2017), existe desigualdade na assistência fornecida aos estrangeiros e brasiguaios, pois considerando o excedente populacional e os repasses de verba insuficientes para saúde, que tem base apenas nos residentes do município, existe grande defasagem financeira no sistema. Quando a origem do estrangeiro é revelada, é possível que as portas dos serviços da saúde se fechem, fazendo com que esta população encontre outros meios extraoficiais de comprovar o endereço na cidade brasileira para receberem assistência.

Sendo assim, é comum que a população flutuante e estrangeiros busquem meios informais de acessarem os serviços públicos, estando sujeitos aos riscos dessa empreitada duvidosa, que envolve longas distancias percorridas por gestantes e puérperas, altos custos com transporte, e genitores em busca de tratamento, ao mesmo tempo que abandonam temporariamente o trabalho e o restante da família no país de origem, e quando retornam, as vezes precisam se manter distantes dos filhos hospitalizados no Brasil, deixando-os desacompanhados e convivendo com os impactos emocionais desta situação (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017).

Frente aos desafios constatados no atendimento as brasileiras moradoras do Paraguai (brasiguaias) e estrangeiras, que buscavam os serviços de urgência em obstetrícia no município de Foz do Iguaçu já no momento do parto, visto que este serviço não poderia ser negado pelo hospital (Mello; Victora; Gonçalves, 2015), e considerando o elevado índice de óbitos infantis decorrentes de casos de desnutrição, foi criado em 1993 o Centro Materno Infantil (CMI - na época), atual Centro de Nutrição Infantil (CENNI). O CENNI é uma instituição não governamental (ONG), dependente de recursos de doações, patrocínios de empresas, bazares, e desde 2007, conta com fundos do Sistemas Integrados de Saúde das Fronteiras - SIS-Fronteiras (Berres; Baggio, 2020).

O CENNI foi fundado com o propósito de fornecer atendimento ambulatorial, e internação-dia para gestantes, puérperas e crianças brasileiras residentes no Paraguai e Argentina (Berres; Baggio, 2020). Atualmente, é referência especializada para o acompanhamento de recém nascidos prematuros em Foz do Iguaçu, e conta com uma equipe

multidisciplinar composta por médico pediatra, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga, assistente social e fisioterapeuta, que buscam prevenir, tratar e proporcionar melhora nos distúrbios de crianças e adolescentes (0-12 anos) em situação de risco (CENNI, 2024).

4 PERCURSO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa com finalidade aplicada, de abordagem qualitativa, objetivo exploratório e natureza de corte transversal. Segundo Minayo (2025), a pesquisa qualitativa visa responder a questões específicas, se preocupando com o nível da realidade que não pode ser quantificado. O enfoque está nos valores, crenças, representações, motivos e atitudes que circundam as relações, processos e fenômenos, transcendendo a linha do observável e atribuindo significados ao comportamento humano. O procedimento técnico utilizado foi o estudo de campo, que conforme Gil (2022), é desenvolvido pela observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas, em que o pesquisador realiza o trabalho de forma pessoal, tendo ele mesmo experiência direta com a situação de estudo, obtendo resultados mais fidedignos.

4.2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O referencial teórico-metodológico embasa-se na fenomenologia social de Alfred Schütz, que investiga os fenômenos subjetivos e intersubjetivos, possibilitando que as verdades críticas sobre a realidade estejam baseadas nas experiências pessoais vivenciadas pelos sujeitos. A escolha deste referencial ocorreu devido a possibilidade de compreender as vivências subjetivas dos genitores em suas relações sociais, fundamentadas nos “motivos porque”, que se referem as experiências já concretizadas, e nos “motivos para”, que tratam das expectativas em relação as redes de apoio e cuidado (Terra *et al.*, 2006; Schütz, 2008).

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA

O campo de pesquisa foi o Centro de Nutrição Infantil (CENNI) do município de Foz do Iguaçu, localizado na região Oeste do estado do Paraná. O CENNI é uma entidade não governamental, fundada em 1993, que oferta assistência multidisciplinar com foco na prevenção, promoção e recuperação de crianças e adolescentes com desnutrição, anemias carenciais, diarreias crônicas, baixo peso, alergias ou intolerâncias alimentares, outros

distúrbios gastrointestinais, neonatos prematuros e pacientes com patologias neurológicas (CENNI, 2024).

No que se refere ao acompanhamento de recém-nascidos prematuros, o encaminhamento ao Centro de Nutrição Infantil (CENNI) ocorre, em geral, após a alta hospitalar das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou das unidades de cuidados intermediários do município. Esses encaminhamentos são realizados, principalmente, por serviços da rede pública de saúde, como hospitais, maternidades e unidades básicas de saúde, quando identificada a necessidade de seguimento especializado em função da prematuridade, baixo peso ao nascer, dificuldades alimentares ou outras condições associadas ao desenvolvimento neonatal (CENNI, 2024).

Nesse contexto, o CENNI passa a atuar como serviço de apoio complementar à rede de atenção à saúde, ofertando acompanhamento multiprofissional voltado ao monitoramento do crescimento, do estado nutricional e do desenvolvimento dessas crianças, além de orientações e suporte aos genitores no processo de continuidade do cuidado após a alta hospitalar (CENNI, 2024).

O município que se realizou a pesquisa é considerado uma zona limítrofe entre as cidades de Puerto Iguazu, Argentina, e Ciudad del Este, Paraguai, portanto, tríplice fronteira internacional. Foz do Iguaçu é um centro turístico e econômico do oeste do Paraná, e um dos locais mais procurados por turistas brasileiros e sul-americanos de forma geral. Possui aproximadamente 260 mil habitantes, e sua característica principal é a diversidade cultural, pois na cidade habitam cerca de 80 nacionalidades, sendo as mais representativas oriundas do Paraguai, China, Argentina e Líbano (Foz do Iguaçu, 2020).

Para Andrade (2022), Foz do Iguaçu como cidade de fronteira é demarcada pelas migrações nacionais e internacionais. Entre os motivos centrais dos movimentos migratórios para a cidade estão: o turismo, voltado ao lazer, envolvendo as Cataratas, Hidrelétrica de Itaipu, e outros locais, o número expressivo trabalhadores que passaram a residir ou frequentar o município desde a construção da Itaipu, e as estruturas do serviço de saúde pública brasileiro. Pois, segundo Hortelan *et al.*, (2019), os moradores dos países vizinhos consideram a assistência a saúde brasileira com maior qualidade, o que acarreta as migrações definitivas e as temporárias, que conforme Zaslavsky e Goulart (2017), são as chamadas migrações pendulares, compreendidas como movimentos cotidianos de indivíduos entre os locais de trabalho, estudo, e residência, ou seja, uma mobilidade temporária com um motivo específico.

4.4 POPULAÇÃO E CRITÉRIOS DO ESTUDO

A população do estudo foi constituída por genitores de recém-nascidos prematuros que vivenciaram a hospitalização de seus filhos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) no município e que realizavam o seguimento do cuidado ao recém-nascido pré-termo na instituição de referência para a continuidade da assistência, o CENNI.

Participaram da pesquisa treze genitores de recém-nascidos prematuros, sendo nove do gênero feminino e quatro do gênero masculino. Os participantes tinham entre 23 e 44 anos. Em relação a nacionalidade, dez dos genitores eram brasileiros (as) e três paraguaios (as). Destes, sete eram residentes na cidade de Foz do Iguaçu-PR, cinco em Santa Terezinha de Itaipu-PR, e um em Cascavel-PR. Quanto a escolaridade, três possuíam Ensino Fundamental Incompleto, dois Ensino Fundamental Completo, três Ensino Médio, três Ensino Superior e dois Doutorado. No que se refere ao estado civil dos participantes, quatro eram casados, uma solteira e oito apresentavam união estável. Dentre os treze genitores, haviam quatro casais, que foram entrevistados individualmente. Ademais, cinco dos participantes possuíam apenas um filho, cinco tinham dois filhos, um tinha quatro filhos e dois tinham três filhos.

Como critérios de inclusão, foram considerados: ser genitor de recém-nascido prematuro com histórico de internação em UTIN; ter idade igual ou superior a 18 anos; residir em município da região de fronteira; compreender e comunicar-se em língua portuguesa ou espanhola; e aceitar participar voluntariamente da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Foram estabelecidos como critérios de exclusão: genitores menores de 18 anos; genitores de recém-nascidos prematuros natimortos; genitores que se encontravam em período muito recente da vivência de internação hospitalar do recém-nascido, definido como até 15 dias após a alta da UTIN; e genitores com limitações cognitivas que inviabilizassem a compreensão das questões propostas ou a participação na entrevista.

4.5 COLETA DE DADOS

A seleção dos participantes ocorreu por meio de amostragem não probabilística, por conveniência. Esse tipo de amostragem caracteriza-se pela inclusão de participantes que se encontram acessíveis e disponíveis para colaborar com a pesquisa, sendo amplamente

utilizada em estudos qualitativos (Freitag, 2018). O número de entrevistas não foi definido previamente, uma vez que, na Fenomenologia Social, a delimitação da amostra ocorre a partir da saturação teórica dos dados, alcançada quando os relatos passam a apresentar repetições e são suficientes para responder ao objeto de estudo (Minayo, 2025; Schütz, 2012).

A saturação teórica foi considerada alcançada quando os relatos passaram a apresentar recorrência de significados e convergência temática, sem o surgimento de novos elementos relevantes para a compreensão do fenômeno investigado. Durante o processo de coleta e análise preliminar das entrevistas, os dados foram continuamente comparados, permitindo identificar padrões de sentido nas experiências relatadas pelos genitores.

A partir da décima primeira entrevista, observou-se repetição dos conteúdos centrais relacionados às vivências da prematuridade, à hospitalização em UTIN e às expectativas em relação à continuidade do cuidado em saúde. Ainda assim, duas entrevistas adicionais foram realizadas com o objetivo de confirmar a estabilidade das categorias emergentes, momento em que se constatou a suficiência do material empírico para responder ao objetivo da pesquisa, totalizando treze participantes.

O contato inicial com o campo de pesquisa foi realizado junto à diretoria executiva do Centro de Nutrição Infantil (CENNI), com o objetivo de obter autorização institucional para o desenvolvimento do estudo. Após essa etapa, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e, mediante aprovação, foi estabelecido contato telefônico e/ou presencial com os participantes para apresentação da pesquisa e agendamento das entrevistas.

A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e junho de 2025, por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas de forma presencial, com duração média de 40 minutos. Do total de entrevistas realizadas, sete ocorreram nas dependências do CENNI e seis no domicílio das participantes, nos municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, respectivamente, sempre em ambientes reservados, a fim de garantir o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das informações. Todas as entrevistas foram iniciadas após a leitura, esclarecimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Embora três participantes fossem de nacionalidade paraguaia, todas as entrevistas foram conduzidas em língua portuguesa. A escolha desse idioma ocorreu em virtude de os

participantes demonstrarem adequada compreensão e fluência na língua portuguesa, realidade frequente na região de tríplice fronteira, onde o contato cotidiano entre Brasil, Paraguai e Argentina favorece o uso compartilhado de diferentes idiomas.

Durante o contato inicial e ao longo da entrevista, verificou-se que não havia dificuldades de comunicação que justificassem a utilização da língua espanhola ou a necessidade de tradução do roteiro de entrevista. Dessa forma, o instrumento foi aplicado integralmente em português, garantindo a compreensão das questões pelos participantes e a fidedignidade dos relatos produzidos no contexto da pesquisa.

O roteiro de entrevista contemplou questões relacionadas às experiências vividas pelos genitores ao longo da gestação, à hospitalização do recém-nascido prematuro na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, à formação do vínculo mãe-bebê e pai-bebê, à percepção do cuidado profissional e às expectativas quanto à continuidade da assistência em saúde. As perguntas foram organizadas de modo a apreender os “motivos porque”, relacionados às experiências concretizadas, e os “motivos para”, vinculados às expectativas e projetos futuros, conforme os pressupostos da Fenomenologia Social de Alfred Schütz.

A primeira entrevista foi utilizada como estudo piloto, com o objetivo de testar o roteiro e os procedimentos metodológicos, conforme recomendado por Bailer, Tomitch e D'ely (2011). Como não houve necessidade de ajustes no instrumento, os dados obtidos nessa entrevista foram incorporados ao corpus de análise. As entrevistas foram conduzidas pelo discente, psicólogo, com experiência em entrevistas clínicas e qualitativas, bem como conhecimento nas áreas de hermenêutica e psicanálise, sob orientação e supervisão do docente orientador, com ampla experiência em pesquisas qualitativas e análise fenomenológica.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS

As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas manualmente. Para garantir o anonimato e a confidencialidade dos participantes, foram utilizados códigos alfanuméricos, sendo “GA” para genitora e “GO” para genitor, seguidos do número correspondente à ordem de realização das entrevistas.

A análise dos dados seguiu os pressupostos da Fenomenologia Social de Alfred Schütz (Caldeira *et al.*, 2025), e foi desenvolvida de forma sistemática em etapas inter-relacionadas. Inicialmente, realizou-se a leitura exaustiva e reiterada das transcrições das

entrevistas, buscando apreender o sentido global das experiências narradas pelos participantes. Em seguida, foram identificadas unidades de significado presentes nos relatos, correspondentes a trechos que expressavam percepções, sentimentos e interpretações dos genitores acerca das vivências relacionadas à prematuridade e ao cuidado ao recém-nascido.

Posteriormente, essas unidades de significado foram agrupadas por proximidade semântica, possibilitando a construção das categorias do concreto vivido. Na etapa seguinte, procedeu-se à análise interpretativa dessas categorias à luz dos conceitos de “motivos porque” e “motivos para”, conforme proposto por Schütz, permitindo compreender tanto as experiências já vivenciadas quanto as expectativas e projetos orientados para o futuro.

Por fim, realizou-se o processo de tipificação do grupo social investigado, buscando identificar características compartilhadas nas experiências dos participantes e construir uma compreensão compreensiva das vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros no contexto da continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira. As categorias resultantes foram então discutidas à luz do referencial teórico da Fenomenologia Social e da literatura científica pertinente.

Considerando que a pesquisa qualitativa reconhece a presença do pesquisador como parte do processo investigativo, buscou-se adotar uma postura reflexiva ao longo de todas as etapas do estudo. O pesquisador responsável pelas entrevistas possui formação em Psicologia e experiência prévia em escuta clínica, o que favoreceu a condução das entrevistas e o estabelecimento de vínculo com os participantes. Ao mesmo tempo, procurou-se manter uma atitude de abertura fenomenológica diante dos relatos, suspendendo julgamentos prévios e evitando interpretações antecipadas das experiências narradas. A supervisão constante do orientador e a discussão crítica das categorias analíticas também contribuíram para minimizar possíveis vieses interpretativos, favorecendo uma compreensão mais fiel das vivências expressas pelos genitores.

4.7 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA

De acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, toda pesquisa envolvendo seres humanos pode implicar riscos de natureza física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual (Brasil, 2012). No presente estudo, os riscos estiveram relacionados principalmente a possíveis desconfortos emocionais decorrentes do

relato de experiências de vulnerabilidade vivenciadas pelos genitores durante a prematuridade e a hospitalização do recém-nascido.

Foram asseguradas medidas de proteção aos participantes, como a possibilidade de interromper a entrevista a qualquer momento, recusar-se a responder questões consideradas desconfortáveis e solicitar encaminhamento para acompanhamento psicológico, caso necessário. Entretanto, durante a realização das entrevistas, não houve necessidade de interrupção ou encaminhamento psicológico, apesar da ocorrência de momentos de emoção, conforme avaliação do entrevistador, psicólogo.

Como benefícios, destacaram-se a possibilidade de autopercepção, reflexão e ressignificação das experiências vividas pelos genitores, além da contribuição do estudo para o aprimoramento das práticas de cuidado em saúde e para o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao recém-nascido prematuro, especialmente em contextos de fronteira.

4.8 PROCEDIMENTOS ÉTICOS

A pesquisa foi desenvolvida em conformidade com os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012). O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), obtendo parecer favorável sob o número 7.532.108 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 87365225.7.0000.0107.

A participação no estudo ocorreu de forma voluntária, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo garantido aos participantes o direito de desistência a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou penalidade. O anonimato e a confidencialidade das informações foram rigorosamente preservados, não sendo possível a identificação dos participantes por terceiros. Após a conclusão da pesquisa e a publicação dos resultados, os dados coletados serão devidamente destruídos.

Com o intuito de assegurar rigor científico à pesquisa qualitativa, foram adotadas estratégias que favoreceram a credibilidade, a consistência e a confiabilidade dos achados. A credibilidade foi buscada por meio da imersão prolongada do pesquisador no campo de estudo, da escuta atenta durante as entrevistas e da transcrição integral dos relatos, preservando a fidelidade das narrativas dos participantes.

A consistência analítica foi garantida pela realização de leituras reiteradas do material empírico, pelo processo sistemático de identificação e agrupamento das unidades de significado e pela discussão das categorias emergentes com o orientador da pesquisa, possibilitando reflexão crítica e validação interpretativa. Além disso, foram preservados registros detalhados das etapas da coleta e da análise dos dados, contribuindo para a transparência do percurso metodológico e permitindo a rastreabilidade das decisões analíticas adotadas ao longo do estudo.

5 RESULTADOS

Os resultados obtidos nesta pesquisa são apresentados e analisados em dois artigos científicos:

I – Entre a UTIN e o ambulatório: O cuidado ao recém-nascido prematuro em região de fronteira:

Este manuscrito, foi submetido, em 22/01/2026, a revista Saúde e Sociedade (ISSN: 1984-0470), que também possui Qualis Capes A2 (2021-2024) em enfermagem, saúde coletiva e psicologia, e utiliza a normativa ABNT para formatação dos trabalhos. Status: Aguardando avaliação do parecerista. Este estudo teve como objetivo compreender as práticas e as influências da equipe de saúde neonatal no processo de cuidado ao recém-nascido prematuro, entre a hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e o seguimento ambulatorial, em uma região de fronteira.

II – Vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros: Da internação à continuidade do cuidado em saúde: O artigo será submetido após as correções da banca examinadora, a Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro – REMUNOM (ISSN: 2178-6925), que possui Qualis Capes A2 (2021-2024) em enfermagem, saúde coletiva e psicologia, e adota as normas ABNT para formatação dos trabalhos. O objetivo do artigo é compreender as vivências de genitores de recém-nascidos prematuros em uma região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

5.1 ARTIGO 1

ENTRE A UTIN E O AMBULATÓRIO: O CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO EM REGIÃO DE FRONTEIRA

RESUMO

A prematuridade configura-se como uma situação de grande complexidade, capaz de repercutir intensamente nas vivências parentais, sobretudo quando implica a hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a manutenção da assistência após a alta. Este estudo teve como objetivo compreender as práticas e as influências da equipe de saúde neonatal no processo de cuidado ao recém-nascido prematuro, entre a hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e o seguimento ambulatorial, em uma região de fronteira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e transversal, fundamentada na Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Participaram 13 genitores de recém-nascidos prematuros acompanhados em serviço de referência. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados à luz dos “motivos porque” da ação social. Os resultados evidenciaram que práticas humanizadas, pautadas no acolhimento, na comunicação sensível e na construção de vínculos, favoreceram a confiança e a continuidade do cuidado, enquanto experiências de desumanização produziram sofrimento, insegurança e rupturas na relação com os serviços de saúde. Conclui-se que as práticas da equipe neonatal influenciam diretamente os projetos de ação dos genitores, sendo a humanização elemento central para a integralidade do cuidado ao recém-nascido prematuro, especialmente em contextos de fronteira.

Palavras-chave: Prematuridade; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Humanização da Assistência; Fenomenologia Social; Cuidado Neonatal.

ABSTRACT

Prematurity is a critical event that profoundly impacts neonatal care and parental experiences, particularly when it involves hospitalization in a Neonatal Intensive Care Unit and continuity of care after discharge. This study aimed to understand the practices and influences of the neonatal health team in the care process of premature newborns, from hospitalization to outpatient follow-up, in a border region. This is a qualitative, exploratory, and cross-sectional study grounded in Alfred Schütz's Social Phenomenology. Thirteen parents of premature newborns followed in a reference service participated. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed based on the “reasons why” of social action. The findings showed that humanized practices—characterized by welcoming attitudes, sensitive communication, and bonding—strengthened trust and continuity of care, whereas experiences of dehumanization generated suffering, insecurity, and ruptures in the relationship with health services. It is concluded that neonatal team practices directly influence parental projects of action, with humanization being a central element for comprehensive care, especially in border contexts.

Keywords: Prematurity; Neonatal Intensive Care Unit; Humanization of Care; Social Phenomenology; Neonatal Care.

INTRODUÇÃO

A prematuridade constitui um evento crítico no curso da gestação, frequentemente associado a intercorrências maternas e fetais que demandam a antecipação do parto e a imediata internação do recém-nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Entre os principais fatores relacionados ao nascimento pré-termo destacam-se condições como pré-eclâmpsia, hipertensão, infecções e doenças crônicas maternas, que colocam em risco a vida da mãe e do bebê (Marchetti; Moreira, 2015). Esse evento implica não apenas maior vulnerabilidade biológica do recém-nascido, mas também repercussões emocionais significativas para os genitores, decorrentes da interrupção abrupta do processo gestacional e da ruptura das expectativas construídas ao longo da gravidez (Lemos; Faria, 2024).

O recém-nascido prematuro, definido como aquele nascido antes de 37 semanas de gestação, apresenta risco aumentado de baixo peso ao nascer, incluindo quadros de muito baixo peso e extremo baixo peso, além de maior incidência de agravos clínicos que exigem cuidados especializados e monitoramento intensivo (Brasil, 2021; Esteves *et al.*, 2023). Essas condições frequentemente demandam internação prolongada em UTIN, configurando um período marcado por elevada complexidade assistencial e por profundas mudanças nas dinâmicas familiares (Giguer; Silva, 2024).

Embora a UTIN seja um espaço fundamental para a sobrevivência e a reabilitação do recém-nascido de alto risco, trata-se de um ambiente altamente tecnológico, frequentemente percebido como hostil e ameaçador pelos genitores, em razão das rotinas rígidas, dos procedimentos invasivos e da limitação do contato físico com o bebê (Baseggio *et al.*, 2017; Giguer; Silva, 2024). A hospitalização prolongada pode interferir no estabelecimento do vínculo inicial entre pais e filho, repercutindo negativamente no desenvolvimento emocional e neuropsicomotor do recém-nascido, sobretudo quando o contato e a interação são restritos pelas normas institucionais (Gallegos-Martinez; Reyes-Hernandez; Scochi, 2013; Camargo *et al.*, 2023).

A experiência da internação em UTIN é atravessada por sentimentos intensos de sofrimento, medo, ansiedade, insegurança e culpa, o que evidencia a necessidade de uma assistência que contemple não apenas o recém-nascido, mas também sua família (Lemos; Faria, 2024; Acosta; Cabrera, 2016). Nesse contexto, a atuação da equipe de saúde neonatal assume papel central, pois suas práticas podem favorecer ou limitar a participação dos genitores no cuidado. Estratégias que estimulem o toque, a fala, a presença e o envolvimento

ativo dos pais contribuem para o fortalecimento do vínculo e para a evolução clínica do recém-nascido, sendo fundamentais para a humanização da assistência (Andrade; Baccelli; Benincasa, 2017).

A utilização de tecnologias em saúde voltadas às relações interpessoais, ao acolhimento e à escuta qualificada tem sido apontada como estratégia essencial para a humanização do cuidado neonatal e para a construção de vínculos entre profissionais e famílias (Zanfolim; Cerchiari; Ganassin, 2018). Essas práticas favorecem a reorganização familiar frente à hospitalização e contribuem para a adaptação à condição de prematuridade, especialmente quando articuladas a uma abordagem ampliada do cuidado, que reconhece a complexidade das interações entre aspectos biológicos, emocionais e sociais (Rezende Tavares; Mota; Magro, 2006).

Com a alta hospitalar, o cuidado ao recém-nascido prematuro se estende ao domicílio e aos serviços ambulatoriais, exigindo continuidade da assistência e preparo adequado da família. Embora a desospitalização seja amplamente desejada, esse momento é permeado por sentimentos ambivalentes, como ansiedade, medo e insegurança diante da responsabilidade pelos cuidados cotidianos e do risco de complicações no desenvolvimento (Estevam; Silva, 2016; Esteves *et al.*, 2023). Considerando o risco aumentado de alterações neurológicas, motoras e comportamentais, torna-se imprescindível a implementação de programas estruturados de seguimento, iniciados ainda durante a internação e mantidos após a alta (Queiroz *et al.*, 2024; Xavier; Bernardino; Gaíva, 2020).

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), políticas públicas e redes de atenção materno-infantil buscam assegurar a integralidade e a continuidade do cuidado ao recém-nascido de risco. Entretanto, em regiões de fronteira, essas estratégias enfrentam desafios específicos, como a sobrecarga dos serviços, a população flutuante, as desigualdades de acesso e as fragilidades na articulação da rede de atenção (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017; Zaslavsky; Goulart, 2017). Em municípios de tríplice fronteira, como Foz do Iguaçu, tais fragilidades impactam diretamente a organização do cuidado e a experiência das famílias, exigindo estratégias complementares, incluindo a atuação de serviços não governamentais, como o Centro de Nutrição Infantil – CENNI (Berres; Baggio, 2020).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo compreender as práticas e as influências da equipe de saúde neonatal no processo de cuidado ao recém-nascido prematuro, entre a hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e o seguimento da assistência ambulatorial, em uma região de fronteira, buscando contribuir para o

fortalecimento de práticas assistenciais mais integradas, humanizadas e contextualizadas às vulnerabilidades territoriais e familiares.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e delineamento transversal, desenvolvido por meio de pesquisa de campo. A abordagem qualitativa foi adotada por possibilitar a compreensão dos significados atribuídos pelos genitores às experiências vivenciadas no cuidado ao recém-nascido prematuro, especialmente no percurso entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e a continuidade da assistência em serviços ambulatoriais (Minayo, 2025).

O referencial teórico-metodológico foi a Fenomenologia Social de Alfred Schütz, que permitiu apreender as ações sociais a partir das experiências subjetivas e intersubjetivas dos participantes, orientadas pelos “motivos porque”, relacionados às vivências passadas em relação ao cuidado e à atuação da equipe de saúde neonatal (Schütz, 2008).

O estudo foi realizado no Centro de Nutrição Infantil (CENNI), localizado no município de Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná, território caracterizado por intensos fluxos migratórios e por sua condição de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Participaram da pesquisa 13 genitores de recém-nascidos prematuros, sendo 09 do gênero feminino e 04 do gênero masculino, 10 brasileiros e 03 estrangeiros, residentes na região de fronteira, que vivenciaram a internação do filho em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no município e realizavam o seguimento do cuidado ao recém-nascido pré-termo no CENNI. Foram incluídos genitores maiores de 18 anos, falantes de português ou espanhol, sendo excluídos genitores menores de idade ou com limitações cognitivas que inviabilizassem a participação.

A seleção dos participantes ocorreu por amostragem não probabilística, por conveniência, e o número de entrevistas foi definido pelo critério de saturação teórica (Minayo, 2025), conforme os pressupostos da Fenomenologia Social (Schütz, 2008). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com duração média de 40 minutos, conduzidas presencialmente entre abril e junho de 2025, após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Das entrevistas realizadas, sete ocorreram nas dependências do CENNI e seis no domicílio dos participantes, nos municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu,

ambas em ambientes reservados, assegurando privacidade e confidencialidade. O roteiro de entrevista contemplou questões relacionadas às vivências durante a gestação, à hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, à formação do vínculo com o bebê, à percepção do cuidado profissional e às expectativas quanto à continuidade da assistência em saúde.

As entrevistas foram gravadas, transcritas manualmente e analisadas sem o auxílio de softwares, seguindo as etapas da Fenomenologia Social: leitura exhaustiva dos relatos, identificação dos aspectos significativos, construção das categorias do concreto vivido, análise dos “motivos porque” da ação social e tipificação do grupo estudado, com posterior discussão à luz do referencial teórico e da literatura pertinente (Caldeira *et al.*, 2025). Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados por códigos alfanuméricos, sendo “GA” para genitora e “GO” para genitor, seguidos do número correspondente à ordem das entrevistas.

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo parecer favorável de número 7.532.108 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 87365225.7.0000.0107.

Os riscos estiveram relacionados a possíveis desconfortos emocionais decorrentes do relato de experiências de vulnerabilidade; contudo, não houve necessidade de interrupção das entrevistas nem encaminhamento para acompanhamento psicológico, apesar da ocorrência de momentos de emoção por parte dos genitores, conforme avaliação do entrevistador, psicólogo. Entre os benefícios, destacam-se a possibilidade de ressignificação das experiências vividas pelos genitores e a contribuição para o aprimoramento das práticas de cuidado e para o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao recém-nascido prematuro em contextos de fronteira.

RESULTADOS

Participaram do estudo 13 genitores, com idades entre 23 e 44 anos, inseridos em diferentes contextos socioterritoriais característicos de uma região de fronteira. Quanto à nacionalidade, 10 participantes eram brasileiros(as) e 3 paraguaios(as). Em relação ao local de residência, 7 genitores residiam em Foz do Iguaçu-PR, 5 em Santa Terezinha de Itaipu-

PR e 1 em Cascavel-PR, o que evidenciou distintas trajetórias de acesso aos serviços de saúde e de continuidade do cuidado após a alta hospitalar.

No que se refere à escolaridade, 3 participantes possuíam Ensino Fundamental incompleto, 2 Ensino Fundamental completo, 3 Ensino Médio, 3 Ensino Superior e 2 Doutorado. Quanto ao estado civil, 4 eram casados(as), 1 solteira e 8 viviam em união estável. Dentre os treze genitores, haviam quatro casais, que foram entrevistados individualmente. Em relação à composição familiar, 5 participantes possuíam 1 filho, 5 tinham 2 filhos, 2 relataram ter 3 filhos e 1 possuía 4 filhos. Além disso, 4 genitores relataram histórico de perdas gestacionais anteriores, aspecto que influenciou a forma como vivenciaram o cuidado neonatal e se relacionaram com a equipe de saúde.

Em relação aos recém-nascidos, 7 foram classificados como prematuros extremos, com idade gestacional entre 24 e 30 semanas, e 6 como prematuros moderados, entre 31 e 36 semanas de gestação. O tempo de internação em UTI/UCI Neonatal variou entre os participantes: 1 recém-nascido permaneceu hospitalizado por período inferior a 7 dias, 5 entre 15 e 30 dias, 4 entre 60 e 90 dias e 3 por mais de 90 dias. Esses diferentes tempos de internação intensificaram, em maior ou menor grau, a convivência dos genitores com a equipe de saúde neonatal, influenciando a percepção sobre as práticas assistenciais adotadas.

A análise dos dados, orientada pela Fenomenologia Social, possibilitou compreender as práticas e as influências da equipe de saúde neonatal no processo de cuidado ao recém-nascido prematuro, desde a hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal até o seguimento da assistência ambulatorial, em uma região de fronteira. As vivências dos genitores evidenciaram como a qualidade da comunicação, o acolhimento, a disponibilidade para o diálogo e o reconhecimento das vulnerabilidades territoriais e familiares impactaram diretamente a construção do vínculo e a continuidade do cuidado.

Os pressupostos da Fenomenologia Social — intersubjetividade, relações sociais, bagagem de conhecimento, reciprocidade de intenções, mundo social, relação face a face e motivação da ação — estiveram presentes ao longo da análise. A partir das entrevistas e do rigor metodológico adotado, foram identificadas duas categorias analíticas compreendidas pelos “motivos porque”, relacionadas às experiências já vividas pelos genitores: “*O cuidado humanizado em saúde como rede de suporte*” e “*A desumanização da equipe de saúde no processo de cuidado*”, que expressam, respectivamente, práticas integradas e acolhedoras e fragilidades assistenciais com repercussões no cuidado ao recém-nascido prematuro e em seu seguimento ambulatorial.

Os discursos dos participantes correspondentes à primeira categoria mencionada são apresentados a seguir:

Então é um carinho muito grande que a gente pega e eu tenho contato de enfermeiras da UTI até hoje, que foi no aniversário dele (premature). (...) , é que nem o psicólogo do hospital, vinha trazia vídeos, trazia fotinhas todos os dias ele ia lá me ver. O Psicólogo foi na segunda, na terça, na quarta, daí quinta eu já tive alta daí quinta eu já fui pro quarto, mas todos os dias que eu fiquei na UTI ele sempre ia lá, levava um fotinha dele, dizia que ele andava bem, então isso aí é uma ajuda nossa tremenda pra gente que tá passando já por um processo difícil né, sem conhecimento né. (...) Eu acredito que os Médicos, a Médica principalmente que tá acompanhando ele, sempre aqui no Centro de Nutrição, assim eu me sinto muito segura, muito segura, sem palavras, as vezes não tem agenda porque é muita gente né, então às vezes uma consulta que, que pra mim eu ficaria mais segura todo mês, demora 2, 3 meses, mas eu fico mais segura assim que eu sei que eu vou passar com ela, não importa se em 1 ou 2 meses. (...) então é um carinho, uma equipe assim que faz a diferença, aqui (CENNI) vou te falar que eu não sei de onde eles tiram tanta força assim, tanto amor pra fazer o trabalho deles, é incrível (GA 03).

Ah a gente imagina uma coisa né, mas entrando na UTI, vendo todos aqueles profissionais preparados sabe, que sabem o que estão fazendo ali, já acalma o coração, a gente fica mais tranquila e receber o jeito que a gente foi recebido lá dentro, podendo ver como que estava sendo feito os cuidados com a criança a qualquer momento que quisesse podia entrar pra poder ver, recebia mensagens de como que a criança tava se não podia ir lá, já deixa a gente mais calmo. O Psicólogo, ele ficava indo lá, e inclusive quando eu não podia também estar lá quando eu estava internada sempre me informava como que a (nome da bebê) estava, porque é uma emoção muito grande de ter o seu filho, mas não poder levar ele pra casa naquele momento né, então sempre ele conversava comigo pra ver como que eu estava né, ia lá e conversava também inclusive com a (nome da bebê) e ela se escuta a voz dele, já conhece. A todo momento a equipe estava ali me auxiliando, me ajudando pra ver se eu ia conseguir amamentar ela, mas a partir do momento que viram que eu não ia conseguir amamentar, daí eles já falaram não, não tem como, mas você não vai ser menos mãe por causa disso. Então participei das rodas de eu não sei o nome certo, mas tem aquelas rodas de reunião né lá dentro, para as mães, então me explicaram tudo e daí lá na UCI eu pude amamentar ela por aquela sondinha, que daí colocava o leite naquela seringa né, e pela sondinha alguns dias. (...) Ah o acompanhamento no CENNI é muito bom porque é um acompanhamento que a gente confia, é porque muita coisa que a (nome da bebê) teve e ainda tem também porque faz o tratamento ainda né, sempre quando eu tenho dúvida eu já tiro minhas dúvidas lá, então muita coisa que a (nome da bebê) teve e tem, foi descoberto por lá, então a gente fica mais tranquila, (GA 04).

Eu peguei ela depois de 15 dias, eu consegui ter o primeiro contato com ela, acho que foi onde eu, eu tive coragem né, de pedir pras meninas, falar que eu queria sentir ela, queria pegar ela no colo, e aí foi feito mãe canguru né, a gente só com aventalzinho e ela era muito pequenininha né

encaixadinha assim, foi tão gostoso. (...) Depois eu fui perdendo o medo, daí ela ficava um tempo, teve episódios que ela ficou sem o tubo né, que ela era um bebê muito difícil, porque, ela foi extubada 7h00 da manhã, quando era 20h00 da noite ela estava entubada de novo, então assim tive momentos de conseguir pegar ela sem estar no tubo de oxigênio, que pra mim eu acho que foi mais fácil né, a gente se sentia mais segura (...) Assim, a equipe me ajudou, todo mundo me apoiou, vieram, conversaram, explicaram né, foi no dia que eu tive com o psicólogo, que precisei bastante, que eu fiquei muito mal lá dentro, e foi um apoio assim que a gente leva pra vida. (GA 05).

Eu sempre falo eu agradeço muito por todos os profissionais que estavam lá dentro que acolheram bem a gente que cuidaram bem dos meus bebês (gemelares), assim as enfermeiras o cuidado o carinho que elas tinham, a delicadeza de vim conversar com a gente né os médicos também assim. (...) O trabalho também do psicólogo de vim conversar, dar uma palavra né, é diferente né, a gente imagina uma coisa diferente no momento de desespero e de dor né. Então assim, eu sempre falo, agradeço de coração as meninas que foram mães enquanto eu não estava lá né que cuidaram da minha filha, que tratavam ela com muito carinho né que cuidaram dele (filho gemelar falecido) também pelos poucos dias, então assim, eu sou eternamente grata por isso (GA 07).

Eu pensava que no Centro de Nutrição era no máximo tirar o peso dela, e passar o leite só para ela, mas não vi que era tudo isso, que vê o tamanho, acompanha o crescimento dela, encaminha para outros serviços (GA 08). Nossa é nos mínimos detalhes que você vê a diferença, a forma que eles abordam ali na UTI, já é diferente, ali eles, como eu posso explicar, é totalmente como se fosse pessoal da família mesmo, tratou a gente super bem ali, davam orientações e tudo. O cuidado quando ele tava na UTI né, eles tinham muito cuidados, explicavam muito bem como proceder a questão até de higiene pessoal lá pra ir pra dentro da sala né, pra não levar doença ou algo do tipo pra dentro também. São bem detalhistas. (...) Ah em relação ao CENNI, é muito boa a relação né, porque o pessoal a gente chega aqui é como se fosse da família, já conhece a história já sabe o que que passamos na UTI, o neném como é que tá e cada vez que chega aqui eles ficam mais, dá pra ver no olhar que eles ficam mais contentes de ver ele bem. (G0 02).

Os relatos dos genitores referentes a segunda categoria, foram:

Daí eu tive cesárea né, ai eu queria beber água, fazia poucas horas que tinha acabado de vir para o quarto e meu bebê estava na UTI, ai a enfermeira falou é só você levantar e ir lá buscar. Falou assim, daí eu meu Deus como é que eu vou levantar, eu acabei de vir para a cama, estou fragilizada ainda, daí eu ah nem vou falar nada, Deus uma hora cobra, eu não vou falar nada, porque eu não gosto de confusão. (...) Na UTI, achei desconfortável também, acho que até para todas as mães, tinha que ter pelo menos uma caminha né, para mim deitar ali do lado, ter aquele conforto ali, tinha que dar uma boa melhorada na estrutura (GA 01).

É, só no dia do parto que eu não gostei muito, porque o meu parto não era para ser parto normal, era para fazer cesárea, mas o médico, o meu médico que estava lá comigo, ele não queria fazer cesárea porque aí eu não estava com os papéis com ele, daí ele me forçou a ter parto normal e eu não queria porque eu já estava, eu já tenho um total de sete filhos. Sim, daí era para mim fazer laqueadura já, e ele não queria. Aí ele me forçou a ter normal, daí eu não tinha mais o que fazer, e eu briguei na hora com ele, aí começou tudo, e parece que pra mim o mundo acabou, esse dia quando ele não fez nada pra mim. O resultado foi meu bebê na UTI. (GA 06).

É, tipo assim também uma enfermeira um dia chegou pra mim na UCI falou assim, ela não conhece a sua voz ela conhece mais a gente do que você. Como que ela não conhece minha voz? Ela nasceu de mim, eu ia visitar a minha filha todos os dias, até duas vezes por dia! Então como que ela não conhece a minha voz? (...) Eu acho que não, pelo contrário, porque eu estava lá todos os dias, sempre que possível eu pedia para segurar ela né, as vezes eu ia até duas vezes por dia, principalmente nos finais de semana, eu ia de manhã para levar a (nome da outra filha), e a tarde eu ia lá e as vezes ficava a tarde inteira lá, no domingo. (...) Teve uma vez que essa mesma enfermeira que falou isso pra mim, foi uma que na primeira vez à noite que eu fui visitar eles né, depois que eu pude levantar, ela falou assim: é o (nome do bebê gemelar) está bem grave, aí ela pegou e saiu e deixou a gente ali, eu não tinha nem visto ele ainda, eu não tinha nem tomado conta da situação porque ele nasceu super bem né, nasceu chorando e tal, só depois que eu recebi a notícia que ele tinha sido intubado e tal. Tipo assim não é papel dela me falar isso, papel é do médico né, então assim ela não deveria ter falado isso. Então ela deixou a gente ali né de mãos atadas né (GA 07).

Nos últimos dias na UTI uma assistente lá que foi bem estúpida comigo, uma vez um outro enfermeiro também na UCI (GA 08).

Eu acho que dentro da UTI tem vários perfis, assim né a equipe é grande, pelo menos ali era grande, a equipe né, tinha equipe diferente dependendo do turno né, então tem vários perfis, eu me identifiquei com alguns, outros nem tanto, tinha técnicas lá que elas eram, a gente percebia o quanto elas eram apaixonadas pelo que elas faziam né, assim elas tinham um carinho, e uma dedicação, elas se entregavam, tinham outras que eram estritamente técnicas né, que era um trabalho né, tinha que cuidar do bebê, enfim né, mas assim tinha algumas que a gente percebia o quanto elas tinham um amor pelos bebezinhos mesmo, não que as que eram técnicas não gostavam, mas era uma coisa mais mecânica assim né, a gente começou a perceber também que às vezes havia um desencontro de informação né, uma pessoa falava alguma coisa, outra falava a outra, em relação, e aí isso começou a nos incomodar, e aí a gente começou a perguntar mesmo né, queria saber o que estava, qual que era a real informação, e aí eles não gostaram né se sentiram acho que incomodados enfim, a médica o tempo todo também fazendo umas comparações que eu achei desnecessárias, tipo falando assim ah que determinado bebê saiu dali sem nenhuma intercorrência porque os pais vinham ali só oravam e eram super positivos, tipo ou seja, não perguntavam, então assim, super desnecessária uma comparação dela, que ela quis dizer que o (nome do bebê) teve intercorrência porque nós não éramos tranquilos né, foi isso que ela quis

dizer. Então eu achei isso de uma falta de humanidade muito grande (GA 09).

Era para ela (esposa) ficar 2 horas no oxigênio, ficou 4 horas e meia tomando oxigênio, porque as enfermeiras deixaram ela a noite inteira com falta de ar, reclamando que estava com dificuldade de respirar, fazendo exercício pra ver se conseguia respirar pra mandar oxigênio pra (nome da bebê) e eu falava, tentava falar com as enfermeiras e elas não escutavam, não acudiram ela a noite inteira” (G0 03).

Na UTI a equipe era bem diferente assim, o pessoal a grande maioria acho que já passam por muita coisa ali, muitas situações, então o tratamento era diferenciado, o pessoal era bem mais vamos dizer assim, acolhedor em alguns momentos ali né, mas tinha algumas outras vezes que eles parece, que não queriam passar muita informação né, ficavam meio que com receio, não queriam falar muita coisa né, a parte de enfermagem técnica só podiam se dirigir a médica, e os médicos às vezes também né eram poucos e tinham que atender muitos, a gente sabe que também o período deles ali era curto. Tinha um horário só de manhã, um horário à tarde pra receber notícia e informação, se tu chegasses um pouquinho atrasado já um pouco mais difícil né também, e nesse ponto parece que não tinha muita empatia né, nisso sabe pelo menos no início, ah chegou atrasado, azar volta amanhã, deu o tempo, não vou passar informação e é isso, ok é como eu disse, às vezes teve um dia ruim, teve uma situação complicada a gente entende isso também né (GO 04).

DISCUSSÃO

A discussão dos achados deste estudo, à luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, permite compreender como as práticas da equipe de saúde neonatal foram significadas pelos genitores a partir de suas experiências intersubjetivas no mundo da vida cotidiana, especialmente no percurso entre a hospitalização em UTIN e a continuidade do cuidado ambulatorial em uma região de fronteira. As ações dos profissionais foram interpretadas pelos participantes a partir de sua bagagem de conhecimentos, construída por vivências prévias, expectativas sociais sobre o cuidado em saúde e pelas situações concretas enfrentadas durante a prematuridade, configurando distintos “motivos porque” da ação social (Schütz, 2012; Schütz; Luckmann, 2017).

A categoria “*O cuidado humanizado em saúde como rede de suporte*” evidencia que, quando a relação face a face entre equipe e genitores foi marcada pelo acolhimento, pela escuta qualificada, pela comunicação clara e pela disponibilidade afetiva, os profissionais passaram a ser compreendidos como parte de uma rede de apoio que sustentou os genitores em um momento de intensa vulnerabilidade. Na perspectiva fenomenológica, tais interações favoreceram a reciprocidade de intenções, uma vez que os genitores perceberam nas ações

dos profissionais não apenas a execução técnica do cuidado, mas a intenção genuína de protegê-los, orientá-los e incluí-los no processo terapêutico do recém-nascido (Schütz, 2012).

Os relatos demonstram que práticas como a mediação do psicólogo, o envio de informações e imagens do bebê, o acolhimento, as orientações empáticas, o incentivo ao método canguru, as rodas de conversas entre mães e equipe, o apoio diante das dificuldades de amamentação e a continuidade do vínculo no seguimento ambulatorial permitiram aos genitores ressignificar a experiência da prematuridade. Essas ações ampliaram o sentido do cuidado para além da dimensão biológica, aproximando-se do que Schütz denomina de mundo social compartilhado, no qual profissionais e famílias constroem significados comuns a partir da convivência e da interação cotidiana (Schütz, 2012; Ayres, 2006).

Achados semelhantes são descritos na literatura, que aponta a humanização do cuidado neonatal como elemento central para o fortalecimento do vínculo parental e para a redução do sofrimento emocional durante a internação (Baseggio *et al.*, 2017; Andrade; Baccelli; Benincasa, 2017).

Ainda nessa categoria, o CENNI emergiu como um espaço de continuidade simbólica e prática do cuidado iniciado na UTIN. Para os genitores, o seguimento ambulatorial não foi percebido apenas como um serviço técnico de monitoramento do crescimento e desenvolvimento, mas como um prolongamento da rede de suporte construída durante a hospitalização. Sob a ótica da Fenomenologia Social, essa continuidade reforça a tipificação positiva dos profissionais e da instituição, que passam a ser reconhecidos como atores confiáveis no projeto de ação dos genitores, orientado à proteção e ao desenvolvimento do filho prematuro (Schütz, 2012; Esteves-Pereira *et al.*, 2025).

Em contraposição, a categoria “*A desumanização da equipe de saúde no processo de cuidado*” revela situações em que a interação profissional–família foi marcada por assimetrias de poder, violência obstétrica, comunicação inadequada, posturas autoritárias e falhas no acolhimento. Tais experiências produziram rupturas na reciprocidade de intenções, fazendo com que os genitores interpretassem determinadas ações como frias, mecânicas ou desrespeitosas. Na perspectiva de Schütz, essas vivências passam a integrar a bagagem de conhecimentos dos sujeitos, influenciando negativamente a forma como atribuem sentido ao cuidado recebido e às instituições de saúde (Schütz, 2008).

Os relatos de imposição de condutas no parto, de falas inadequadas sobre o vínculo mãe-bebê, de comunicação de informações graves por profissionais não responsáveis e de

negligência diante do sofrimento materno evidenciam fragilidades éticas e relacionais no cuidado. Essas situações reforçam o caráter hierarquizado das relações em saúde, no qual o saber técnico se sobrepõe à experiência subjetiva dos genitores, desconsiderando o contexto emocional e social em que se encontram. Estudos prévios também apontam que práticas desumanizadas na UTIN intensificam sentimentos de medo, culpa e impotência, comprometendo a confiança na equipe e a participação parental no cuidado (Acosta; Cabrera, 2016; Lemos; Faria, 2024).

A diversidade de perfis profissionais mencionada pelos participantes ilustra, ainda, a coexistência de diferentes tipificações de ação no interior da mesma instituição. Enquanto alguns profissionais foram percebidos como vocacionados e afetivamente envolvidos, outros foram compreendidos como estritamente técnicos, orientados por uma lógica operacional. Para Schütz, essa heterogeneidade de ações reflete distintos sistemas de relevância que orientam o agir no mundo social, os quais, quando não compartilhados ou explicitados, geram conflitos de sentido e insegurança para os atores envolvidos (Schütz, 2012).

No contexto específico de uma região de fronteira, tais fragilidades assumem maior complexidade. As dificuldades de acesso, a sobrecarga dos serviços, a rotatividade de profissionais e as barreiras socioculturais podem limitar a construção de relações intersubjetivas mais sólidas e contínuas. Nesse cenário, a ausência de comunicação sensível e de articulação entre os pontos da rede de atenção tende a ampliar o sentimento de desamparo dos genitores, impactando o seguimento do cuidado após a alta hospitalar. Os achados corroboram estudos que destacam a necessidade de estratégias assistenciais contextualizadas às vulnerabilidades territoriais, especialmente em municípios de tríplice fronteira (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017; Zaslavsky; Goulart, 2017).

De modo geral, os resultados indicam que as práticas da equipe de saúde neonatal influenciam diretamente os projetos de ação dos genitores em relação ao cuidado do recém-nascido prematuro. Quando ancoradas em relações face a face empáticas e humanizadas, tais práticas favorecem a confiança, o engajamento parental e a continuidade do cuidado. Em contrapartida, experiências de desumanização passam a integrar os “motivos porque” da ação social, produzindo desconfiança, sofrimento e, por vezes, afastamento dos serviços (Schütz, 2008).

À luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, conclui-se que a humanização do cuidado neonatal não se limita à adoção de protocolos, mas se concretiza nas interações cotidianas, na forma como os profissionais reconhecem os genitores como sujeitos de

experiência e coautores do cuidado. Em regiões de fronteira, investir na qualificação das relações interpessoais, na comunicação e na articulação da rede de atenção mostra-se fundamental para a construção de práticas mais integradas, sensíveis e socialmente contextualizadas, capazes de responder às complexas demandas do cuidado ao recém-nascido prematuro e sua família (Schütz, 2008; Esteves-Pereira *et al.*, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, os resultados deste estudo evidenciaram que as práticas da equipe de saúde neonatal exercem influência direta na forma como os genitores significam a experiência da prematuridade e constroem seus projetos de ação em relação ao cuidado do recém-nascido. As interações estabelecidas ao longo do percurso assistencial, desde a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal até o seguimento ambulatorial, configuraram-se como espaços privilegiados de produção de sentidos, ancorados na bagagem de conhecimentos e nas vivências intersubjetivas dos genitores.

Práticas pautadas no acolhimento, na comunicação clara, na escuta sensível e na disponibilidade afetiva favoreceram a reciprocidade de intenções, fortalecendo vínculos e promovendo a confiança na equipe e nos serviços de saúde. Em contrapartida, experiências marcadas pela desumanização, assimetrias de poder e falhas comunicacionais passaram a integrar os “motivos porque” da ação social, produzindo sofrimento, insegurança e, por vezes, distanciamento dos serviços.

No contexto de uma região de fronteira, tais experiências assumem maior complexidade, em virtude das vulnerabilidades territoriais, da sobrecarga dos serviços e das fragilidades na articulação da rede de atenção. Os achados ressaltam a importância de estratégias assistenciais contextualizadas, que reconheçam os genitores como sujeitos de experiência e coautores do cuidado, ampliando a integralidade da atenção ao recém-nascido prematuro.

Sendo assim, nota-se que a humanização do cuidado neonatal não se restringe à adoção de protocolos institucionais, mas se concretiza nas interações cotidianas e na qualidade das relações face a face estabelecidas entre profissionais e famílias. Investir na qualificação das práticas relacionais, especialmente em territórios de fronteira, mostra-se

fundamental para a construção de cuidados mais integrados, sensíveis e socialmente contextualizados.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, D. F.; CABRERA, E. A. Vivências parentais frente à hospitalização do recém-nascido prematuro em unidade de terapia intensiva neonatal. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 24, e2755, 2016. Disponível em: <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1144>. Acesso em: 06 jun. 2013.

ANDRADE, L. C.; BACCELLI, M. S.; BENINCASA, M. A. A. Humanização da assistência em unidade de terapia intensiva neonatal: percepção dos pais. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 22, n. 3, p. 393–404, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-24902017000100004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 10 jun. 2023.

AYRES, J. R. C. M. Cuidado e humanização das práticas de saúde. In: **DESLANDES, S. F.** (org.). *Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 49–69. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001756641>. Acesso em: 18 jan. 2026.

BASEGGIO, D. B. *et al.* Vivência de mães de recém-nascidos prematuros em unidade de terapia intensiva neonatal. **Revista de Enfermagem da UFSM**, Santa Maria, v. 7, n. 1, p. 109–120, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2017000100010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 jun. 2023.

BERRES, R.; BAGGIO, M. A. Redes de apoio ao cuidado infantil em contexto de fronteira. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 44, n. 125, p. 789–801, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/MS799NsJTM79MxDYbV8XKZR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 de out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha>. Acesso em: 02 nov. 2024.

CALDEIRA, S. *et al.* Perspectivas de homens autores de violência intrafamiliar em fronteira internacional. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 17, n. 5, p. 1-18, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/8500>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CAMARGO, F. C. *et al.* Interação pais–bebê prematuro na unidade neonatal: implicações para o desenvolvimento infantil. **Revista Paulista de Pediatria**, São Paulo, v. 41, e2021256, 2023. Disponível em:

<<https://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta/article/view/13736/10151>>. Acesso em: 08 de nov. 2024.

ESTEVAM, L. D.; SILVA, L. J. Continuidade do cuidado ao recém-nascido prematuro após a alta hospitalar. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 69, n. 4, p. 721–728, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/4161/2745>. Acesso em: 01 nov. de 2024.

ESTEVES, A. P. *et al.* Seguimento ambulatorial do recém-nascido prematuro: desafios e perspectivas. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 5, p. 1457–1466, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/MyYXjZKbLc9KgBCJ3VxXscz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. de 2023.

ESTEVES-PEREIRA, A. P. *et al.* Práticas hospitalares e amamentação no Brasil: dados da Pesquisa Nascer no Brasil II. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 59, supl. 1, e240568, 2025. Disponível em: <https://rsp.fsp.usp.br/pt-br/article/praticas-hospitalares-e-amamentacao-no-rio-de-janeiro-dados-da-pesquisa-nascer-no-brasil-ii/>. Acesso em: 15 jan. 2026.

GALLEGOS-MARTÍNEZ, J.; REYES-HERNÁNDEZ, J.; SCOCHI, C. G. S. El vínculo madre-hijo en la unidad de cuidados intensivos neonatales. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 21, n. 3, p. 1–8, 2013. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/76061>. Acesso em: 16 jun. 2023

GIGUER, T. M.; SILVA, L. R. Experiência parental na unidade de terapia intensiva neonatal: implicações emocionais e relacionais. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 24, n. 1, p. 55–63, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/PVksjVX8BtdwwwjqcbgMh9m/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2024.

LEMO, L. O.; FARIA, A. M. O impacto emocional da prematuridade na parentalidade. **Psicologia: Teoria e Prática**, São Paulo, v. 26, n. 1, ePTP26105, 2024. Disponível em: <https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cadernospsicologia/article/view/4139/3077>. Acesso em: 01 nov. 2024.

MARCHETTI, D.; MOREIRA, M. E. L. Prematuridade: fatores de risco maternos e neonatais. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 91, n. 1, p. 15–22, 2015. Disponível em: <https://www.pssa.ucdb.br/pssa/article/view/408>. Acesso em: 12 jun. 2023.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 15. ed. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 2025.

QUEIROZ, A. B. A. *et al.* Programas de seguimento do recém-nascido prematuro: evidências e recomendações. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 58, p. 12, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qFr7SPZMv8nYVW5pCMn97Lh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 04 nov. 2024.

REZENDE TAVARES, C.; MOTA, D. D. C. F.; MAGRO, M. C. S. O cuidado à família do recém-nascido em terapia intensiva neonatal. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 59, n. 1, p. 87–92, 2006. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4060/406038915005.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2023.

SCHÜTZ, A. **Fenomenologia do mundo social**. Petrópolis: Vozes, 2012.

SCHÜTZ, A. **Sobre fenomenologia e relações sociais**. Petrópolis: Vozes, 2008.

SCHÜTZ, A.; LUCKMANN, T. **As estruturas do mundo da vida**. Petrópolis: Vozes, 2017.

SILVA, R. M.; UGOSKI, M.; DRAVANZ, G. M. A organização da atenção à saúde em regiões de fronteira. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 764–776, 2017. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/27121/15754>. Acesso em: 18 out. 2024.

XAVIER, D. M.; BERNARDINO, E.; GAÍVA, M. A. M. Continuidade do cuidado ao recém-nascido de risco na rede de atenção à saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 4, e20180958, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9515/8527>. Acesso em: 20 out. 2024.

ZANFOLIM, L. C.; CERCHIARI, E. A. N.; GANASSIN, G. S. Humanização e tecnologias leves no cuidado neonatal. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 22, n. 66, p. 1063–1074, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/xKpVCkhpQLgm8bPqRSZZ97L/?lang=pt#>. Acesso em: 10 jun. 2023.

ZASLAVSKY, R.; GOULART, B. N. G. Migração, fronteiras e acesso aos serviços de saúde. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 1161–1180, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qmqyF5sw58GvC7qBCrpS4Hn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 nov. 2024.

5.2 ARTIGO 2

VIVÊNCIAS DOS GENITORES DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS: DA INTERNAÇÃO À CONTINUIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE

RESUMO

A prematuridade configura-se como um evento crítico que impacta de forma significativa a experiência parental, sobretudo quando envolve a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado após a alta hospitalar. Este estudo objetivou compreender as vivências de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em UTIN e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória e transversal, fundamentada na Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Participaram 13 genitores acompanhados em serviço de referência no sul do Brasil. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas, analisadas segundo os “motivos porque” e os “motivos para” da ação social. As vivências dos genitores foram marcadas por sofrimento emocional, medo da perda, ruptura de idealizações e resignificação da UTIN como espaço de cuidado. Alterações psicológicas, como ansiedade e exaustão, foram frequentes e atenuadas por redes de apoio. A alta hospitalar configurou-se como transição ambígua, exigindo reorganização da vida cotidiana e maior protagonismo parental.

Palavras-chave: Saúde na fronteira; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Continuidade do cuidado; Fenomenologia Social, Tríplice Fronteira.

ABSTRACT

Prematurity constitutes a critical event that significantly impacts the parental experience, especially when it involves hospitalization in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and the continuity of care after hospital discharge. This study aimed to understand the experiences of parents of premature newborns between NICU hospitalization and the continuity of healthcare in a border region between Brazil, Paraguay, and Argentina. This is a qualitative, exploratory, and cross-sectional study grounded in Alfred Schütz's Social Phenomenology. Thirteen parents followed up at a reference service in southern Brazil participated. Data were produced through semi-structured interviews and analyzed according to the “reasons why” and the “reasons for” of social action. Parental experiences were marked by emotional distress, fear of loss, disruption of idealizations, and the re-signification of the NICU as a space of care. Psychological changes, such as anxiety and exhaustion, were frequent and mitigated by support networks. Hospital discharge emerged as an ambiguous transition, requiring reorganization of daily life and greater parental protagonism.

Keywords: Border health; Neonatal Intensive Care Unit; Continuity of care; Social Phenomenology; Triple Frontier.

RESUMEN

La prematuridad se configura como un evento crítico que impacta de manera significativa la experiencia parental, especialmente cuando implica la hospitalización en una Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) y la continuidad del cuidado tras el alta hospitalaria. Este estudio tuvo como objetivo comprender las vivencias de los progenitores de recién nacidos prematuros entre la internación en la UTIN y la continuidad del cuidado en salud en una región de frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Se trata de una investigación cualitativa, exploratoria y transversal, fundamentada en la Fenomenología Social de Alfred Schütz. Participaron 13 progenitores acompañados en un servicio de referencia del sur de Brasil. Los datos se produjeron mediante entrevistas semiestructuradas, analizadas según los “motivos por qué” y los “motivos para” de la acción social. Las vivencias de los progenitores estuvieron marcadas por sufrimiento emocional, miedo a la pérdida, ruptura de idealizaciones y resignificación de la UTIN como espacio de cuidado. Las alteraciones psicológicas, como ansiedad y agotamiento, fueron frecuentes y atenuadas por redes de apoyo. El alta hospitalaria se configuró como una transición ambigua, que exigió la reorganización de la vida cotidiana y un mayor protagonismo parental.

Palabras clave: Salud en la frontera; Unidad de Terapia Intensiva Neonatal; Continuidad del cuidado; Fenomenología Social; Triple Frontera.

INTRODUÇÃO

A gravidez constitui um processo permeado por intensos sentimentos e emoções, no qual relações, identidades parentais e histórias infantis são resignificadas diante do desejo e da possibilidade de uma nova realidade que se interpõe. Nesse período, os genitores vivenciam a elaboração de planejamentos pessoais, familiares e sociais, fantasias e expectativas em relação ao futuro, frequentemente idealizando uma gestação sem intercorrências e a chegada de um filho saudável, capaz de perpetuar valores, vínculos e características familiares (Castro; Germano; Ferreira, 2019).

Todavia, o planejamento familiar nem sempre se concretiza conforme o esperado. Em determinadas situações, intercorrências clínicas durante a gestação tornam necessária a interrupção precoce do curso gestacional como medida terapêutica para preservação da vida materna e fetal. A prematuridade, definida como o nascimento ocorrido antes de 37 semanas completas de gestação, resulta em condições clínicas desfavoráveis à manutenção da vida no ambiente extrauterino, uma vez que os sistemas orgânicos do recém-nascido ainda se encontram imaturos, demandando cuidados especializados e, frequentemente, internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (Neves; Ravelli; Lemos, 2010).

A prematuridade configura-se como um relevante problema de saúde pública em escala global. Dados da World Health Organization e do United Nations Children's Fund

indicam que, anualmente, aproximadamente 30 milhões de bebês nascem prematuros em todo o mundo (World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2018). O Brasil figura entre os dez países com maiores índices de prematuridade, apresentando uma prevalência estimada em 11,7% dos partos, percentual semelhante ao observado em países de baixa renda, cuja taxa média é de 11,8% (Brasil, 2021). Esses indicadores evidenciam a magnitude do fenômeno e seus impactos sobre os sistemas de saúde, especialmente no âmbito da atenção especializada e do cuidado longitudinal.

Quando o nascimento ocorre de forma antecipada e o recém-nascido necessita de internação em UTIN, os genitores podem vivenciar intenso sofrimento emocional, que podem ser expressados em sentimentos de medo, angústia, insegurança e impotência. Esse sofrimento decorre tanto das mudanças abruptas na dinâmica e organização familiar quanto da preocupação constante com a sobrevivência e recuperação do recém-nascido, além da desconstrução das idealizações e expectativas construídas ao longo da gestação (Zanfolim; Cerchiari; Ganassin, 2018).

O ambiente hospitalar, particularmente o da UTIN, impõe limites e desafios adicionais aos genitores. Em muitas instituições, o acompanhamento contínuo não é permitido, exigindo dos pais uma reorganização subjetiva para lidar com um espaço frequentemente percebido como estranho e hostil, caracterizado pela presença constante de tecnologias, equipamentos, luzes intensas, ruídos, procedimentos invasivos e dolorosos aos quais o recém-nascido é submetido diariamente (Cruz Dantas *et al.*, 2015). Essas condições podem fragilizar o vínculo inicial entre genitores e bebê, bem como intensificar o sofrimento psíquico parental.

Quando o tratamento em UTIN é bem-sucedido e o recém-nascido prematuro alcança estabilidade clínica, inicia-se uma nova etapa do cuidado, que se estende para além da alta hospitalar. O acompanhamento do recém-nascido pré-termo (RNPT) permanece, no mínimo, até os 24 meses de vida, envolvendo atendimentos na Atenção Primária à Saúde (APS) e em ambulatorios especializados. A transição da UTIN para o domicílio demanda da família cuidados específicos e contínuos, uma vez que os genitores passam a assumir integralmente a atenção ao bebê, embora frequentemente não se sintam suficientemente preparados para tal responsabilidade (Brassarola; Natarelli; Fonseca, 2023).

Nesse contexto, evidencia-se a relevância da preparação da família desde o início da internação, estendendo-se ao período pós-alta, com destaque para o papel educativo da equipe de enfermagem e dos demais profissionais de saúde. A continuidade da assistência

requer dos genitores participação ativa, busca constante por aprendizado, disponibilidade de tempo, investimento emocional e flexibilidade para adaptação às demandas do cuidado especializado.

Esses desafios assumem contornos ainda mais complexos em regiões de fronteira. O município de Foz do Iguaçu, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, integra a 9ª Regional de Saúde do Paraná e configura-se como referência no atendimento à gestação de alto risco e à neonatologia. A região atende não apenas a população residente, mas também indivíduos provenientes de municípios vizinhos e de países limítrofes, que se deslocam para acessar serviços especializados, seja durante a internação em UTIN, seja no seguimento ambulatorial no Centro de Nutrição Infantil (CENNI) (Hirano *et al.*, 2023).

Muitos desses genitores enfrentam longos deslocamentos, precariedade socioeconômica e afastamento de seus lares, trabalhos e redes de apoio para acompanhar o tratamento do filho prematuro. Conforme dados da Plataforma Integrada de Vigilância do Ministério da Saúde, somente em 2025, foram registrados 476 nascidos vivos prematuros na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, que abrange diversos municípios da região oeste do Paraná (Brasil, 2025). Ademais, por se tratar de uma região fronteira, é frequente a presença de estrangeiros não residentes que acessam o Sistema Único de Saúde (SUS), motivados pela gratuidade, pela qualidade da assistência ofertada e pela proximidade geográfica, sobretudo diante da percepção de precariedade dos sistemas de saúde dos países vizinhos (Hortelan *et al.*, 2019).

O Brasil possui uma extensa faixa de fronteira, definida constitucionalmente como uma área de 150 km de largura, abrangendo 588 municípios distribuídos em diferentes estados da federação (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017). Essa região, que totaliza aproximadamente 15.719 km de extensão territorial, caracteriza-se por baixo desenvolvimento socioeconômico, marcantes desigualdades sociais, culturais e econômicas e intensas interações transfronteiriças, sobretudo em cidades gêmeas, onde a procura por serviços de saúde por brasileiros não residentes e estrangeiros é expressiva (Foz do Iguaçu, 2020).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo compreender as vivências de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e corte transversal, fundamentada no referencial da Fenomenologia Social de Alfred Schütz. O referencial da Fenomenologia Social permitiu compreender a vivência de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira, conhecer as experiências, dificuldades e alterações emocionais vivenciadas no cotidiano de vida destes genitores e identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas, no âmbito das relações sociais. Essa abordagem mostrou-se adequada para compreender as vivências subjetivas e intersubjetivas de genitores de recém-nascidos prematuros, a partir dos sentidos atribuídos às experiências relacionadas à hospitalização em (Schütz, 2008; Bessa *et al.*, 2023).

O estudo foi realizado no Centro de Nutrição Infantil (CENNI), localizado no município de Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná, área caracterizada por intensos fluxos migratórios e por sua condição de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O CENNI constitui serviço de referência regional para o seguimento de recém-nascidos prematuros, atendendo população residente e indivíduos provenientes de municípios vizinhos e de países limítrofes (CENNI, 2024).

Participaram da pesquisa treze genitores de recém-nascidos prematuros, sendo nove do gênero feminino e quatro do gênero masculino, dez brasileiros e três estrangeiros, todos residentes na região de fronteira. Os participantes vivenciaram a internação do filho em UTIN no município de Foz do Iguaçu-PR e realizavam o seguimento do cuidado ao recém-nascido pré-termo no CENNI.

Foram incluídos participantes maiores de 18 anos, falantes de português ou espanhol, e excluídos aqueles menores de idade ou com limitações cognitivas que inviabilizassem a participação na entrevista. A seleção dos participantes ocorreu por amostragem não probabilística, por conveniência. O número de entrevistas foi definido por saturação teórica, conforme os pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa e da Fenomenologia Social (Minayo, 2025).

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas presencialmente entre abril e junho de 2025, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos e foram realizadas em ambiente reservado, de modo a garantir a privacidade e a confidencialidade.

Sete entrevistas ocorreram nas dependências do CENNI e seis no domicílio das participantes, localizados nos municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu (PR). O roteiro de entrevista, elaborado pelos pesquisadores com base na literatura, foi estruturado com 24 questões, destas 15 referiam-se a dados sociodemográficos, 01 contemplou questões relacionadas às experiências vividas durante a gestação, 02 a hospitalização na UTI Neonatal, 01 a formação do vínculo com o bebê, 03 a percepção do cuidado profissional e as expectativas em relação à continuidade da assistência em saúde. As entrevistas foram conduzidas por pesquisador com formação em Psicologia e experiência em pesquisa qualitativa.

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas integralmente de forma manual, sendo posteriormente analisadas sem o auxílio de softwares específicos. A análise dos dados fundamentou-se na Fenomenologia Social de Alfred Schütz, seguindo etapas sistemáticas que incluíram a leitura exaustiva dos relatos, a identificação dos aspectos significativos, a construção das categorias do concreto vivido, a análise dos “motivos porque”, associados às experiências já vividas, e dos “motivos para”, relacionados às expectativas e projetos futuros dos sujeitos da ação social, bem como a tipificação do grupo social investigado (Caldeira *et al.*, 2025; Schütz, 2008; Bessa *et al.*, 2023).

Os resultados foram, então, interpretados à luz do referencial teórico adotado e da literatura científica pertinente a área da saúde. Para assegurar o anonimato, os participantes foram identificados por códigos alfanuméricos, nos quais “GA” designa genitora e “GO” genitor, seguidos da numeração correspondente à ordem das entrevistas.

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo o parecer favorável de número 7.532.108 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética: 87365225.7.0000.0107.

Os riscos da pesquisa estiveram relacionados a possíveis desconfortos emocionais decorrentes do relato de experiências de vulnerabilidade. Foi assegurado aos participantes o direito de interromper a participação a qualquer momento, bem como o encaminhamento para atendimento psicológico, caso necessário. Não houve necessidade de interrupção das entrevistas nem de encaminhamento psicológico, embora tenham sido observados momentos de emoção durante os relatos, avaliados e acolhidos pelo entrevistador, psicólogo.

Entre os benefícios, destacaram-se a possibilidade de ressignificação das experiências vividas pelos genitores e a contribuição para o aprimoramento das práticas de

cuidado e de políticas públicas voltadas ao recém-nascido prematuro, especialmente em contextos de fronteira.

RESULTADOS

Participaram do estudo, treze genitores, com idades entre 23 e 44 anos. Quanto a nacionalidade, dez eram brasileiros (as) e três paraguaios (as). No que se refere ao local de residência, sete participantes residiam no município de Foz do Iguaçu (PR), cinco em Santa Terezinha de Itaipu (PR) e um em Cascavel (PR).

Em relação à escolaridade, três participantes apresentavam Ensino Fundamental incompleto, dois Ensino Fundamental completo, três Ensino Médio completo, três Ensino Superior completo e dois Doutorado. No que concerne ao estado civil, quatro eram participantes casados (as), um(a) solteiro (a) e oito relataram viver em união estável. Dentre os treze genitores, haviam quatro casais, que foram entrevistados individualmente. Quanto à composição familiar, cinco participantes tinham um filho, cinco possuíam dois filhos, dois relataram ter três filhos e um participante tinha quatro filhos. Ademais, quatro genitores relataram histórico de perdas gestacionais anteriores. As informações sobre os genitores encontram-se detalhadas na Tabela 01.

Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos genitores.

Genitor (a)	Gênero	Idade	Nacionalidade	Estado Civil	Cidade de residência	Formação	Quant. de filhos	Histórico de perda gestacional
GA 01	Feminino	26	Brasileira	União estável	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Fund. Incompleto	3	-
GA 02	Feminino	23	Brasileira	União estável	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Fund. Incompleto	2	-
GA 03	Feminino	33	Brasileira	União estável	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Médio Completo	1	-
GA 04	Feminino	30	Brasileira	União estável	Cascavel-PR	Ensino Médio Completo	1	2
GA 05	Feminino	39	Brasileira	Casada	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Superior Completo	2	5
GA 06	Feminino	35	Paraguaia	Solteira	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Fund. Completo	3	4
GA 07	Feminino	32	Brasileira	Casada	Santa Terezinha do Itaipu-PR	Ensino Superior Completo	4	-
GA 08	Feminino	32	Brasileira	União estável	Santa Terezinha do Itaipu-PR	Ensino Médio Completo	2	1
GA 09	Feminino	37	Brasileira	Casada	Santa Terezinha do Itaipu-PR	Doutorado	1	-
GO 01	Masculino	27	Paraguaio	União estável	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Médio Incompleto	2	-
GO 02	Masculino	38	Brasileiro	União estável	Foz do Iguaçu-PR	Ensino Superior Completo	1	-
GO 03	Masculino	44	Paraguaio	União estável	Santa Terezinha do Itaipu-PR	Ensino Fund. Incompleto	2	-
GO 04	Masculino	42	Brasileiro	Casado	Santa Terezinha do Itaipu-PR	Doutorado	1	-

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2026).

No que se refere aos recém-nascidos, sete foram classificados como prematuros

extremos, com idade gestacional entre 24 e 30 semanas, e seis como prematuros moderados, entre 31 e 36 semanas de gestação. Quanto ao tempo de internação em UTI/UCI Neonatal, um recém-nascido permaneceu hospitalizado por período inferior ao de sete dias, cinco entre 15 e 30 dias, quatro entre 60 e 90 dias e três por período superior a 90 dias. As características clínicas e assistenciais dos recém-nascidos prematuros encontram-se detalhadas na Tabela 02.

Tabela 2 - Informações dos prematuros.

Genitor (a)	Idade gestacional	Tempo de internação
GA 01	34 semanas	2 dias
GA 02	33 semanas	20 dias
GA 03	35 semanas	15 dias
GA 04	29 semanas	65 dias
GA 05	26 semanas	96 dias
GA 06	35 semanas	15 dias
GA 07	29 semanas e 4 dias	74 Dias
GA 08	29 semanas	117 dias
GA 09	29 semanas	78 dias
GO 01	33 semanas	20 dias
GO 02	35 semanas	15 dias
GO 03	29 semanas	117 dias
GO 04	29 semanas	78 dias

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2026).

Os pressupostos da Fenomenologia Social de Alfred Schütz estiveram amplamente presentes ao longo da investigação, destacando-se a intersubjetividade, as relações sociais, a bagagem de conhecimento, a reciprocidade de intenções, o mundo social, a relação face a face e a motivação, compreendida a partir dos “motivos porque” e os “motivos para”. A partir da análise das entrevistas, foram identificadas quatro categorias e duas subcategorias concretas do vivido, compreendidas a luz dos “motivos porque” e duas categorias concretas do vivido compreendidas através dos “motivos para”.

As categorias associadas aos “motivos porque”, vinculadas às experiências já vividas pelos genitores são: 1. Os tabus sobre a UTI e as vivências concretas da prematuridade; 1.1. Idealização (subcategoria); 1.2. Vínculo parental (subcategoria); 2. Aspectos psicológicos e emocionais da prematuridade; 3. Redes de apoio e 4. Continuidade do Cuidado. Por sua vez, as categorias referentes aos “motivos para”, relacionados às expectativas e projetos futuros, compreendem: 5. Expectativas quanto a si mesmo(a) e 6. Expectativas em relação ao(à) futuro do filho(a);

A Categoria, intitulada 1. *Os tabus sobre a UTI e as vivências concretas da prematuridade*, expressa o modo como os genitores compreendem a prematuridade, os significados atribuídos a UTI e os tabus socialmente construídos em torno desse contexto, bem como as experiências concretas vivenciadas durante a internação do(a) recém-nascido(a) prematuro (a).

Pra mim foi sofrido, só queria chorar e o medo, porque vir o que vem da UTI não é coisa boa assim né, tinha muito medo de eu perder ela, muito medo, até então o dia que me falaram que ela teve a parada, meu Deus, meu mundo acabou ali. Lembro que eu só chorava, queria pegar ela, eu não podia ainda, a gente quer pegar como mãe, eu só chorava. Não foi como eu quis (GA 02).

Eu não sabia também o que que a gente esperava né, então eu deixei as coisas acontecerem, não tinha nada arrumado estava tudo lá guardado, mas, não tinha nada arrumado e daí a gente teve que lidar então com a prematuridade. Muitos bebês foram, muitos bebês partiram e eu vi né, e tudo isso mexe muito com a gente né, até porque eu passei por isso lá dentro né, mais assim, no primeiro momento foi um pouco assustador sabe, aí depois eu já entrava com aquele sentimento de apreensão, aí meu Deus, o que eu vou encontrar lá dentro né, será que a notícia vai ser boa, será que a notícia vai ser ruim, como é que será que passou a noite, então eu já entrava assim, com apreensão, com medo, com dor de barriga, tudo que você imaginar. Muitas vezes eu saía chorando, muitas vezes eu não acreditava no que eu escutava, e assim a gente ia (GA 07).

Foi um mix de emoção para falar a verdade, eu estava feliz por que a minha filha estava viva e ao mesmo tempo preocupada porque ela estava na UTI e eu também não podia ver ela (...) eu só falava para minha cunhada, cuida minha filha, olha como é que tá minha filha, olha. A única coisa que me marcou que me deixou meio apavorada, um dia que eu fui visitar a (nome do bebê), nas ultimas vezes que eu fui lá para ela fazer a cirurgia da inversão, de um nenémzinho que tinha morrido lá de um dos gêmeos, aquilo lá me deixou meio apavorada. Eu pensava que não ia sair de lá, eu falava meu Deus do céu, acho que eu vou morar no hospital. Antes quando eu vinha para casa eu ficava meio perdida, agora que eu estou acostumando com a rotina da casa, por que minha mente querendo ou não, eu sai do hospital, mas parece que a mente ainda fica lá, tem vez que eu sonho como pi pi pi (barulho), vem na minha mente até hoje (GA 08).

(...) tudo que pode acontecer na prematuridade, intercorrências, sequelas a longo prazo, desde deficiência enfim tudo né, eu não tinha essa ideia, daí quando eu comecei a pesquisar eu fiquei em pânico, eu fiquei apavorada né, porque todos os estudos falam que um prematuro extremo dificilmente sai sem sequelas né, deficiência visual, deficiência intelectual, paralisia, era o que mais tinha né, então eu fiquei muito assim, sei lá, ansiosa né. Ali aonde o (nome do bebê) ficou na UTI é um corredor imenso pra chegar na UTI, aquele corredor pra mim parecia que era uma eternidade sabe, então assim eu chegava no hospital parecia que eu já sentia aquela aceleração assim, porque eu não sabia o que que eu ia encontrar lá né, e a primeira vez que eu fui pra UTI porque foi logo no outro dia né que eu estava internada, eu me lembro assim eu fiquei impactada com tamanho, então eu fui lá pra ver ele de manhã, após o parto eu fiquei impactada com o tamanho dele. (...) eu não lembro de ter saído algum dia de lá sem chorar naquele corredor da UTI né, porque deixar ele sem saber que se durante a noite ele ia ficar bem? Será que ele não ia chorar? Será? Ah era muito ruim, então eu acho que a UTI é esse afastamento né (GA 09).

Olha, então, eu não conhecia a UTI Neonatal né, eu não posso nem te falar que o pouco que eu vi na TV, era algo, porque ali é totalmente diferente né os aparelhos podem ser iguais da TV né, mas o tratado humano ali muda completamente. Eu tinha expectativa de que ia ser, a UTI uma equipe que chegava como se fosse um robzinho, chegava na hora marcada só, e fazia medicamento, olhava, estava tudo bem e tal e saía, mas não, parece que são mães e pais que trabalham ali, que tem um cuidado né 24h00, parece que não descansam. Eu chegava lá, eu ia pra casa voltava e tinha a equipe estava lá já pronta de novo, felizes trabalhando e tranquilos e sempre preparados, cuidando atentos a detalhes, é totalmente diferente se eu criar algo, uma ideia do tipo que seria, eu não faria tão perfeito assim (GO 02).

Muitas coisas podem acontecer, mas o mais difícil de tudo eu acho ali na UTI, foi você acompanhar outras histórias também né, algumas que se desenvolviam bem e outras nem tão bem assim né, muitas às vezes a gente presenciou alguns ali que teve óbitos de bebê, e aí você ficava pensando também né, poxa, para a nossa sorte não foi o nosso né, chegou até parece ser egoísta pensar assim né, porque tem uma mãe, um pai ele sofrendo e tal, mas é isso, você não tem que fazer, você só tem que olhar pro seu, porque você não tem muito como ajudar né (GO 04).

A Subcategoria 1.1 *Idealização*, contempla as construções subjetivas dos genitores em relação a gestação, bebê idealizado, parto planejado, estabelecimento de vínculo inicial e das expectativas relacionadas aos cuidados com o recém-nascido (RN). Tais elementos podem ser evidenciados nas seguintes falas:

Meu Deus, como eu posso dizer, eu imaginava uma outra coisa, eu pensei que ia ser uma gravidez normal, bem normal, porque no outro foi tranquilo, até então quando eu descobri eu tive sangramento e tal, eu tive que ficar em repouso, mas eu pensei que ia ser normal, igual do (nome do outro filho). (...) Sem chá de bebê, daí todo mundo falou, porque que não fez mesmo assim, seu marido vinha, recebia os presentes, mas não é a mesma coisa, a gente quer ta ali, a gente quer participar, eu estava no hospital, eu me internei numa quarta-feira, no sábado era o chá dela (GA 02).

Eu não tive a sensação de ganhar o neném, porque eu fui intubada também, eu não vi nascer, esse aí eu sinto falta sabe o primeiro contato assim de ver, saiu de mim... escutar os primeiros chorinhos, esse aí eu creio que é uma falta que eu tenho (GA03).

Difícil, muito difícil, difícil pra mim, porque eu tinha outros sonhos, sonho de ter aquela barrigona enorme, de entrar no hospital, de filmar minha filha nascendo, eu não tenho uma foto do parto né, tive infelicidade, minha filha nasceu morta, ela precisou ser reanimada. Difícil, bem difícil, difícil porque a gente né, no meio onde eu trabalho eu convivo com muitas crianças né, muitas crianças que infelizmente não pediram pra vir ao mundo, e tão ali lindas, perfeitas e vê que a criança não é cuidada sabe, isso me revolta muito e eu enquanto mãe da (nome do bebê) a gente não espera né que o filho da gente seja uma criança atípica, e a gente sabe infelizmente que essas crianças sofrem, infelizmente, sofrem preconceito, sofrem de acesso à saúde, se você não tem uma condição boa eles sofrem né (GA 05).

Na verdade, eu não planejei ter ele, foi uma troca de remédio. Troca de remédio e tudo, eu não queria ter ele. No começo eu fui no Psicólogo, eu passei mal, eu tentei tirar a vida, tudo (GA 06).

(...) Devido ao repouso aquelas idealizações que eu tinha né, de algumas coisas eu posterguei né, para fazer depois que eu tivesse talvez uma melhora né. Então fazer tipo ensaio fotográfico, fazer chá né, e tinha postergado um pouco, não imaginava que eu ia ter um parto prematuro, então eu tinha postergado pra depois dos sete meses né, depois dos sete meses de gestação eu ia fazer essas coisas, até porque a minha barriguinha ela era muito pequena, então nem parecia que eu estava gestante. Aí só que não deu tempo né, não deu tempo, porque aí depois tive outro sangramento, aí veio o diagnóstico. (...) então isso é uma coisa que também foi mais uma idealização que eu acho que não aconteceu né, que foi amamentação né, e aí eu tinha amigas que tiveram, amigas não conhecidas que depois surgiram né, que eu nem sabia, que tiveram bebês prematuros em outros locais né, e elas puderam tirar o leite o tempo todo de internação na UTI e eu não pude, aqui não pode, então é uma coisa que eu senti falta (GA 09).

A Subcategoria 1.2. *Vínculo parental*, reúne os relatos dos participantes sobre como a prematuridade e as práticas de cuidado em saúde interferiram no processo de estabelecimento de vínculo afetivo com o(a) filho(a), bem como suas repercussões na dinâmica familiar atual:

Então, é eles me mostravam ela através das fotos, dos vídeos, mas os períodos também que eu estava bem, eles levavam de cadeira de rodas até na UTI para ver ela. (...), mas a todo momento eu ficava passando pra ela que eu a amava, passava a mão nela e estava ali perto dela, eu acho que o nosso vínculo se transformou, ficou forte igual, só que é diferente, não é a mesma coisa que você tá em casa poder pegar a criança, abraçar, beijar e conversar, lá se conversava assim pegava a mãozinha da criança, mas não é a mesma coisa que você pegar no colo. Mas acho que o vínculo, acho que é um vínculo bom igual. (...) Inclusive eu chorei muito, porque eu queria muito amamentar a (nome do bebê) né, nossa era o meu sonho. (GA 04).

Olha, eu só consegui pegar a minha filha no colo uns 10 dias depois, por aí, uns 10 dias, quando eu consegui pegar ela no colo, sentir ela pela primeira vez né, porque antes eu tinha até medo de tocar, porque ela estava toda cheia de fios né, cheia de tubos. E ela era um cisquinho né, uma coisinha magrinha só tinha bochecha. Ela nasceu com 1,050 kg, então assim, pra mim foi difícil né, muito difícil construir esse vínculo com ela estando lá dentro, foi bem difícil, porque a gente não podia tocar a gente tinha medo de tocar né, trazer alguma coisa de fora, por mais que era higienizada né, que a gente trocava de roupa na hora de entrar ali dentro eu principalmente trocava camiseta tudo né, pra entrar na sala da incubadora. A gente morria de medo de passar alguma coisa pra ela, então eu acho que foi mais difícil criar um vínculo, a gente demorou pra criar um vínculo né (GA 05).

Acho que a internação influenciou um pouco, por que ela não... agora que ela está começando a se acostumar um pouco comigo, porque ela não queria nem subir no meu colo, assim, só a mãe dela, só a mãe dela, entendeu. Agora parece que começou a mudar, brinca comigo, eu falo com ela, ela dá risada (GO 01).

Mas a gente percebia que quando a gente estava perto, ele gostava, com uma espécie de um sorriso, ele sentia que a gente estava ali né, e a gente tentou o máximo possível estar lá, só que não tem muita estrutura pra você ficar na UTI né, e também a gente entende que o espaço é pequeno né, tem muitas coisas que tem que tá fazendo, e imagina se cada pai, cada mãe ficasse o tempo todo (GO 04).

A Categoria 2. *Aspectos psicológicos e emocionais da prematuridade*, evidencia as principais repercussões emocionais e subjetivas vivenciadas pelos genitores no contexto da prematuridade. Os relatos expressam sentimentos como medo, angústia, insegurança e sofrimento psíquico associados ao nascimento prematuro e ao período de internação do(a) recém-nascido(a). Destaca-se que, entre os participantes, três genitoras relataram histórico prévio de transtornos psicológicos, incluindo quadros de depressão e ansiedade, bem como episódios de sofrimento psíquico significativo. Todas informaram ter realizado acompanhamento psicológico e psiquiátrico, encontrando-se em estabilidade clínica há mais de um ano no momento da pesquisa. Alguns dos discursos ilustrativos dessa categoria são apresentados a seguir:

Assustador né, foi assustador, entrei lá, será que o bebê está bem? Daí olhei naquele negocinho, com sonda ali, eu que já tenho ansiedade, comecei a passar mal já (GA 01).

No domingo ela já foi pra UTI, aí eu vi minha vida virar de ponta cabeça completamente, porque não conhecia nada, nem ninguém dali, e por tudo que ela estava passando, pra mim foi tudo muito tumultuado. (...) porque é uma emoção muito grande de ter o seu filho, mas não poder levar ele pra casa naquele momento né, então sempre o psicólogo conversava comigo pra ver como que eu estava né, ia lá e conversava também inclusive com a (nome do bebê) e ela se escuta a voz dele, já conhece. (...) estava feliz por trazer ela logo pra casa, mas também com medo de sair dos aparelhos do hospital e não conseguir saber como que ela ia estar né, os primeiros meses foi, eu nem dormia, porque eu ficava com medo de dormir e a menina parar de respirar (...) (GA 04).

Era desesperador vim pra casa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu só me sentia bem quando eu estava lá dentro (UTI), olhando pra ela por mais que lá dentro era difícil né, a gente conviveu com as crianças lá dentro, a gente, eu presenciei muita mãe saindo lá de dentro de braço vazio. (...) um dos dias que mais me marcou, que eu cheguei um dia e um bebê tinha morrido, que era o bebê do lado da incubadora dela, e eu não consegui dormir essa noite. No outro dia eu cheguei bem cedo, eu vi que a (nome do bebê) tinha sido mudada de incubadora, e eu não tinha sido comunicada nem que ela tinha trocado (...) eu cheguei olhei a incubadora dela estava vazia, e numa incubadora do outro lado cheio de gente em volta e eles estavam raspando a cabeça dela e eu passei muito mal e desmaiei lá na frente né. E assim, ela estava bem, naquele dia era um dos dias melhores que ela estava lá dentro, e foi o dia assim que pra mim eu perdi o chão, porque eu achei que a minha filha tinha morrido (GA 05).

Então, olha para ser bem sincera assim, eu não consigo te expressar como que eu consegui, eu só ia, por que eu tinha que ir né, mas assim eu chegava lá eu olhava pra incubadora eu falava nossa ele (filho gemelar que havia falecido) poderia estar ali, ele poderia estar ali, ou lembrava ele assim de alguns de alguns lapsos né, então eu sempre lembrava assim, mas eu só ia porque eu tinha que ir eu, tinha eu tinha que estar lá com minha filha né. (...) eu não tive tempo de ter aquele luto, sabe, e eu não sei, eu tenho impressão assim, como ele não foi para casa, eu não senti tanto, e as vezes eu me sinto culpada por causa disso, por não sentir tanto, mas eu sinto muito, mas eu acho que se as vezes tivesse ido para casa, teria sido pior (GA 07).

Então assim, a UTI ela tem altos e baixos né, você chega lá um dia, tipo tá bem está estável né, progredimos nisso a gente sai de lá super feliz, feliz assim, pela situação que ele não tá ruim, mas tristes. Eu nunca saí de lá assim, tipo sempre triste, sempre saí lá com uma tristeza por deixar ele lá né (GA 09).

É, eu pensava um pouco diferente assim da minha esposa, eu era muito positivo nessa parte sabe, tem umas coisas que eu sou mais pessimista, mas nessa parte eu era muito positivo, eu preferia escolher pensar o positivo né, então eu estava assim, porque assim, eu não podia demonstrar naquele momento ali ansiedade né, fraqueza e medo, porque ela já estava sentindo isso, e eu não podia passar isso pra ela, ainda mais essa sobrecarga, então eu tinha que ser o lado positivo da voz ali (GO 04).

A Categoria 3, referente aos “motivos porque”, aborda as redes de apoio mobilizadas pelos genitores no enfrentamento da prematuridade, evidenciando o papel do suporte familiar, social e institucional no processo de cuidado, adaptação e enfrentamento das demandas decorrentes do nascimento prematuro:

“Quando me dá crise de ansiedade, eu gosto de ir na igreja, se eu não vou na igreja, tipo assim, eu entro em depressão profunda, aí eu não quero comer, eu não quero sair, eu não quero conversar com ninguém, eu me tranco, se eu não ir para a igreja, eu me tranco, entendeu (GA 01).

Não tinha familiares, nem conhecidos e nem conhecia nada em Foz, foi tudo muito novo. (...) a gente é católico, temos muita fé, então todos os dias teve uma rede de oração muito grande pela (nome do bebê), faziam novena de oração, faziam novena na igreja, fizeram caminhada de uma cidade pra outra de Tupãssi a Brasileira, se eu não me engano. Também fizeram uma caminhada de oração pra ela, então assim a fé era muito grande e eu nunca pensava ah vamos sair dali sem a (nome do bebê) não, ia sair do hospital com a (nome do bebê), mas ela deu vários sustos. (...) Tem sempre do lado da UTI, eles sempre deixavam também a gente ficar ali, rezando orando, mas tem a igreja também né, aquele pedacinho, a igreja dentro do hospital, então batia ponto ali todo dia também. (...) Ahh eu quero, igual eu falei, todos foram muito profissionais a gente fez muitos amigos, fizemos uma família né, aí também porque até os dias que eu estava na UTI com a (nome do bebê) alguns profissionais me chamavam vamos lá em casa um pouquinho pra poder espairecer um pouco a cabeça né, ficar mais tranquila, por a gente não morar em Foz (GA 04).

Eu tive muito apoio do meu marido né, ele trocou de emprego, ele brigou com o mundo, com o céu e o mundo, largou a profissão que ele mais ama no mundo né, que era chefiar uma equipe de cozinha, ele era chefe de cozinha né, abriu mão de vários empregos várias proposta, pra ficar ali comigo, pra me acompanhar, porque eu às vezes dava doida 3h00 da manhã eu quero ir pra UTI, acordava e quero ir pra UTI, batia o pé e me levava. (...) Eu tive muito apoio religioso né, de dentro da igreja que a gente estava frequentando, muito joelho no chão, tive apoio do psicólogo do hospital, da equipe de dentro do hospital, o apoio foi super importante deles, aí acho que foi o que ajudou mais foi o meu esposo que era o que sempre a paz que ele falava que ela iria sair de lá, que ia tudo dar certo e eu sempre desesperada (GA 05).

(...) Até porque o (nome do bebê) tinha uma especialidade né, ele tinha uma alergia a proteína do leite de vaca, e isso requer uma alimentação específica, e muito cara, dependendo do poder aquisitivo de alguém é uma coisa que pesa muito no

orçamento sabe, muito no orçamento, então assim eram 3.700 por mês só em leite sabe, então foi muito difícil daí esse tipo de coisa ajudou bastante, porque o de início ali era um pouco menos, mas o centro (de nutrição) ajudava muito, às vezes tinha uma lata ou outra que eles conseguiam pra gente e a gente ia comprando né, porque aqui em Santa Terezinha eles até tem um programa no município que fornecem algumas coisas, só que aquele específico não. O que dava certo é o apoio incondicional que a gente tem e se coloca junto assim enquanto casal né, a gente se dá muito bem, e eu acho que uma coisa importante é isso sabe, essa parceria que sempre teve e isso foi muito importante, então assim eu fico pensando a dificuldade que deve ser né porque a gente viu pessoas lá que não tinham essa parceria assim sabe de casa (GO 04).

A Categoria 4, ainda referente aos “motivos porque” *Continuidade do Cuidado*, descreve as vivências dos genitores no período pós-desospitalização, evidenciando os desafios, adaptações e estratégias de cuidado adotadas no acompanhamento do(a) recém-nascido(a) prematuro(a) após a alta hospitalar:

A partir do momento que a gente veio pra casa continuou com as os exames, avaliações, os médicos, porque ela saiu de lá só que os cuidados permaneceram né, então teve muito exame pra fazer, teve muito cuidado com quem que ia tipo assim aí não pode né muita gente muito próximo no começo porque era um bebezinho que ainda o pulmão ainda não, até hoje né não tá 100% (...) é nós seguimos sendo cuidadas ali pelo Centro de Nutrição, é muito bom porque é um acompanhamento que a gente confia, e porque muita coisa que a (nome do bebê) teve e ainda tem, ela faz tratamento. Sempre quando eu tenho dúvida eu já tiro minhas dúvidas lá, então muita coisa que a (nome do bebê) teve e tem, foi descoberto por lá, então a gente fica mais tranquila. (...) Mesmo morando longe de Foz, a gente acaba indo pra lá para ser atendido, porque vale muito a pena né. (GA 04).

Assim, é difícil porque hoje eu dependo totalmente de rede particular pros tratamentos dela né, o SUS me oferece meia hora de tratamento, e ainda assim é muito, a distância muito grande onde eu tenho que ir. Eu levo 50 minutos com trânsito bom pra chegar né até o acompanhamento dela, pra terapia, pra fono, pra tudo, é um tempo muito curto pra uma criança que precisa tanto né. Hoje assim, a gente tem meios né a gente se vira tem o carro né, eu tenho bastante pessoas que me ajudam, faço rifa pra poder custear os tratamentos que são pagos né, ela é atendida no CENNI, mas é muito difícil uma consulta lá, às vezes a consulta com a pediatra que acompanha ela tá demorando em torno de 60 dias de uma consulta pra outra. Ela consultou com a doutora que acompanha ela, que é a pediatra faz três meses e nós vamos ter uma consulta agora dia 16 do mês que vem, então assim é uma quantidade muito grande de espera né. (...) é muita gente na fila, brasileiros, paraguaios, todo mundo é atendido ali. (GA 05).

A gente faz de tudo um pouco, porque a gente saiu de lá com uma lista enorme de especialidades para procurar e exames para fazer, e a gente não sabia nem por onde começar, então o primeiro passo foi que a gente decidiu que a gente queria tentar conversar com as próprias médicas que atendiam ele na UTI mesmo, e tentar dar essa sequência com elas como pediatra né. Então, só que elas têm uma agenda bem complicada, a gente sabe, mas elas atendiam ali no centro materno (nutrição) lá né de acompanhamento a prematuros, então o primeiro contato foi com eles né, e conseguimos aí umas consultas com elas lá, isso ajudou bastante assim, bastante mesmo (GO 04).

No que tange aos “motivos para,” a Categoria 5. *Expectativas quanto a si mesmo*, reúne os relatos dos participantes acerca das projeções, expectativas e reorganizações subjetivas relacionadas a si próprios, construídas a partir da experiência da prematuridade:

Nem tive tempo na verdade de pensar em mim, sempre foi o (nome do bebê) né, desde que ele saiu, é tudo é para ele, tudo. Eu sempre falo assim, que ele estando de banho tomado e cheirosinho e alimentado é o que importa, depois eu penso em mim (GA 03).

Eu pra mim não tem mais futuro, só para eles, eu pra mim não vejo nada, se você me olhasse no passado e agora, eu ia falar que não acredito (GA 06).

Eu espero que dê tudo certo, que eu quero voltar a trabalhar, e não voltei a trabalhar ainda né, por conta da correria da neném, e eu quero voltar a trabalhar de novo, nem que for por casa, mas eu quero voltar a trabalhar, conciliar os dois (GA 08).

Acho que muda tudo, você muda o centro da sua vida, não é porque antes o centro da sua vida era você né, as coisas eram a partir da sua rotina, dos seus desejos né, das suas expectativas, agora não mais, eu acho que o centro é outro né, então eu retomei sim a minha atividade profissional, enquanto estudante estou finalizando a minha tese, mas assim não com a rotina que eu tinha, é com a rotina que dá né, então estou terminando minha tese da forma que dá, e pra mim tá tudo bem também (GA 09).

Ahh só felicidade”. É uma fase que a gente pensa, que a gente passa né e agora tem um ano e três meses aí, e aí às vezes vai passando aquele momento de dificuldade inicial e aí você começa a pensar de volta um pouco na vida no planejamento de volta em você também, como pai agora. Eu vejo que né, ganhei um companheiro né, gosta de tá junto, você pode chegar em casa cansado do serviço e ele tá lá brincando, esperando pra brincar nossa é surreal, só expectativas boas né, acredito que ganhei um companheiro aí pro resto da vida (GO 02).

Meus planos é continuar trabalhando, prosperando na vida para poder dar um bom futuro para eles né, porque a gente só pensa na família né, dia e noite só pensando nisso ai né (GO 03).

No âmbito dos “motivos para” a Categoria 6 traduz as Expectativas em relação ao futuro do filho(a), expressa as projeções, esperanças e planos futuros elaborados pelos genitores em relação ao desenvolvimento, à saúde e ao percurso de vida do(a) filho(a), conforme evidenciado nos relatos a seguir:

Ela me surpreende muito, porque a maioria falava que ela podia demorar, ter atraso, e ela não tem nada, eu pensava totalmente outra coisa, mas não me surpreende mais. Falavam outra coisa para mim, e eu colocava aquilo na minha cabeça, e agora não. Ela ta bem avançada para a idade dela (GA 02).

Hoje eu tenho uma rotina bem grande com a (nome do bebê) né, ser mãe de prematuro, de criança atípica é difícil né, hoje a (nome do bebê) tem um diagnóstico de paralisia cerebral né, ela é um bebê de um ano e sete meses, ela não fala, ela não anda né, eu sou professora e a gente a gente compara, não adianta querer dizer que não, que a gente olha e fala, olha minha filha deveria estar fazendo

isso e hoje ela não tá. Eu estou fazendo tudo que me fala que é melhor pra ela, tanto de medicação, quanto de terapia, quanto de auxílio, de tudo pra ela conseguir lá na frente ter um desenvolvimento como uma criança normal né, entendo que ela tem as os limites dela né, mas eu enquanto mãe eu espero que daqui pra frente ela consiga desenvolver a fala, que ela consiga ter um andar né (GA 05).

Espero que ela não fique com sequelas, graças a Deus não deu nada, porque visão e audição dela estão perfeitas. Os movimentos dela, em casa eu fico ali estimulando brincando eu falo que judiando, ela é bem espuletinha, graças a Deus, eu vejo que tá perfeito (GA 08).

Ah espero que ela não tenha mais complicações, esperamos que evolua bem, que continue assim, que ela está evoluindo bem, ta indo muito bem (GO 01).

Eu acho que a (nome do bebê) só está surpreendendo nós, cada vez desenvolvendo mais, esperta, espero ver daqui uns dias ela caminhando, correndo, fazendo bagunça, porque ela gosta da bagunça né, começou a fazer bagunça é com ela, é o show dela né, está surpreendendo nós (GO 03).

DISCUSSÃO

A compreensão das vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros, no percurso que se estende da internação em UTIN e à continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira, revelou experiências profundamente marcadas por sofrimento, ressignificações e reconstruções subjetivas, inscritas no mundo da vida cotidiana dessas pessoas. À luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, os achados revelam que tais vivências extrapolam à dimensão individual, constituindo-se a partir de relações intersubjetivas, de um estoque de conhecimentos socialmente compartilhado e de projetos orientados para o futuro (Schütz, 2008).

Os relatos associados à Categoria “1. O tabu sobre a UTI e as vivências concretas da prematuridade”, indicam que o conhecimento prévio dos genitores acerca da prematuridade e da UTIN encontra-se fortemente permeado por representações sociais negativas, construídas a partir de experiências indiretas, discursos sociais e informações fragmentadas. Esses elementos integram o estoque de conhecimentos à mão, que orienta a interpretação inicial da realidade vivida. Nesse contexto, a UTIN surge como um espaço simbólico associado à morte, à perda e à incerteza, intensificando sentimentos de medo, angústia e apreensão diante da hospitalização do(a) filho(a) (Schütz, 2009).

Entretanto, a experiência concreta da internação, promoveu um deslocamento dessas tipificações prévias. A convivência cotidiana com a equipe multiprofissional, especialmente nas relações face a face, possibilitou aos genitores ressignificarem o significado atribuído a UTIN, passando a percebê-la também como um espaço de cuidado, acolhimento e

preservação da vida. Tal movimento ilustra a reciprocidade de intenções descrita por Schütz, na qual a ação do outro é compreendida como dotada de sentido e orientada por propósitos compartilhados, favorecendo a construção de vínculos de confiança entre genitores e profissionais de saúde (Schütz, 2012).

Nesse cenário, destaca-se a relevância da adoção de tecnologias em saúde, que perpassem os processos de acolhimento, como propõe Coelho e Jorge (2009). As autoras classificam as tecnologias em leves, leve-duras e duras, sendo as tecnologias leves aquelas centradas nas relações. Sua utilização favorece a humanização do cuidado, o gerenciamento dos processos de atenção integral, a prevenção de agravos e a promoção e recuperação da saúde, fortalecendo os laços entre trabalhadores da saúde e usuários.

A Subcategoria “1.1 *Idealização*”, evidencia a ruptura entre os projetos biográficos dos genitores e a realidade imposta pela prematuridade. As idealizações relacionadas à gestação, ao parto e ao contato inicial com o bebê foram abruptamente interrompidas, gerando frustração, luto simbólico e sofrimento psíquico. Sob a perspectiva fenomenológica, tais experiências podem ser compreendidas como a desorganização do curso esperado da ação, na qual os “motivos para” previamente construídos tornam-se inviáveis, exigindo a reelaboração dos sentidos atribuídos à parentalidade e à própria identidade dos genitores (Caldeira *et al.*, 2025).

Os resultados indicam que algumas idealizações frustradas estiveram amplamente presentes no mundo subjetivo dos genitores, como a expectativa de gestação sem riscos e intercorrências, a realização de rituais simbólicos (chá de bebê, ensaios fotográficos), o parto programado ou domiciliar, a chegada de um bebê grande e saudável, e a amamentação imediata, frequentemente inviabilizada pelo baixo peso do recém-nascido. Baseggio *et al.* (2017) caracterizam a UTIN como ambiente marcado por estímulos intensos e procedimentos contínuos, a temperatura é controlada e os pacientes são submetidos a vários procedimentos médicos cotidianamente, o que pode gerar angústia e estranhamento nos genitores, visto que ainda estão presos a imagem de um bebê imaginado, distante da realidade do bebê frágil e pequeno.

No que se refere ao “1.2. *Vínculo parental*”, os achados demonstram que a prematuridade e as restrições impostas pelo ambiente da UTIN interferem de maneira significativa na construção do vínculo afetivo entre pais e filhos. O contato limitado, mediado por tecnologias e normas institucionais, gera sentimentos ambíguos, oscilando entre o desejo de proximidade e o medo de causar danos ao recém-nascido. Ainda assim, os

relatos indicam que o vínculo é construído de forma singular, adaptadas às possibilidades concretas do contexto vivido, reafirmando o caráter intersubjetivo da experiência parental mesmo em condições adversas (Schütz, 2008).

A literatura aponta que os contatos iniciais dos genitores com seu bebê prematuro, por meio de toques envolventes, se transformam em massagens e carícias, e são fundamentais para o estabelecimento de vínculo e recuperação da saúde do RN, devendo ser estimulados e ampliados pela equipe de saúde. (Andrade; Baccelli; Benincasa, 2017). O vínculo inicial, aliado à interação verbal, favorece o desenvolvimento e a evolução clínica do prematuro, sendo imprescindível que a assistência contemple não apenas o bebê, mas também os familiares envolvidos no processo de hospitalização (Acosta; Cabrera, 2016).

A Categoria “2. Aspectos psicológicos e emocionais da prematuridade” revela que a vivência da internação e da continuidade do cuidado é atravessada por intensas alterações emocionais, incluindo ansiedade, medo, culpa, tristeza e exaustão. A presença de histórico prévio de sofrimento psíquico em algumas genitoras potencializa a vulnerabilidade emocional diante da prematuridade, evidenciando a necessidade de atenção integral à saúde mental desses sujeitos. (Zanfolim; Cerchiari; Ganassin, 2018). A UTIN configura-se como um espaço de instabilidade emocional, no qual a estabilidade clínica do bebê reorganiza, de forma contínua, as expectativas e emoções dos genitores, configurando uma experiência marcada pela imprevisibilidade.

Uma das genitoras destacou em sua fala sobre o enfrentamento do luto pelo filho recém-nascido, irmão gemelar da filha prematura, ocorrido na UTIN. Segundo a mesma, não houve tempo para elaboração e resignificação da perda, pois a filha continuava internada em estado grave, e mesmo que ambos os genitores não tivessem o desejo de voltar a frequentar o espaço da UTI após o evento traumático, não tinham outra opção. Este caso revela uma característica da UTIN : a morte como uma constância. As falas de outros quatro participantes reforçam, inclusive, o impacto emocional gerado nos genitores ao constatarem que a morte se fazia presente no local, ainda que não na incubadora de seu filho(a).

Ressalta-se que entre os 13 entrevistados, seis dos genitores destacaram a importância do suporte psicológico recebido durante a internação do(a) prematuro(a) em UTI, sendo que destes, dois dão seguimento ao acompanhamento psicológico, na Unidade Básica de Saúde (UBS) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), respectivamente. Segundo Gieger e Silva (2024), o papel do psicólogo no contexto da prematuridade, seja no ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, permite um espaço de confiança em que os

genitores podem expressar seus sofrimentos e frustrações e serem acolhidos, ressignificando e reorganizando suas vivências junto ao filho e a nova realidade cotidiana.

No âmbito da Categoria “3. *Redes de apoio*”, os resultados demonstram que o enfrentamento da prematuridade é sustentado por diferentes formas de suporte social, incluindo a família, o companheiro, a equipe de saúde, a fé religiosa e os serviços institucionais. Sob a ótica da Fenomenologia Social, essas redes constituem importantes recursos do mundo social, que oferecem sentido, pertencimento e sustentação emocional aos genitores (Schütz, 2008). Em contexto de fronteira, tais redes assumem relevância ainda maior, uma vez que muitos participantes vivenciam o afastamento do território de origem, a fragilização das condições socioeconômicas e a limitação do acesso a recursos materiais e simbólicos (Silva; Ugoski; Dravanz, 2017).

Para Fleck *et al.* (2025), a família e a espiritualidade são as principais estratégias de enfrentamento utilizadas frente a momentos difíceis. Neste sentido, estes elementos de apoio auxiliam na elaboração e ressignificação do processo desafiador, permitindo o encontro de maior conforto, fé, esperança e um novo propósito por parte do sujeito que o enfrenta.

No que diz respeito a Categoria “4. *Continuidade do Cuidado*” destaca-se que a experiência da prematuridade não se encerra com a alta da UTIN, estendendo-se de forma significativa para o cotidiano domiciliar por meio da continuidade do cuidado em saúde. Os relatos evidenciam que a desospitalização é vivenciada pelos genitores como uma transição ambígua, marcada simultaneamente por alívio e por intensificação das responsabilidades, uma vez que os cuidados especializados, exames e acompanhamentos permanecem como parte constitutiva do mundo da vida familiar (Esteves *et al.*, 2023). Sob a perspectiva da Fenomenologia Social, essa continuidade pode ser compreendida como a incorporação de novos significados e práticas ao estoque de conhecimentos à mão, que passam a orientar as ações cotidianas dos genitores (Capalbo, 2008).

Nesse contexto, os serviços de seguimento ambulatorial assumem papel central na reorganização da vida dos genitores, especialmente quando se configuram como espaços de vínculo, confiança e reciprocidade de intenções (Schütz, 2008). O acompanhamento em serviços especializados, como o Centro de Nutrição Infantil, é significado como um prolongamento do cuidado iniciado na UTIN, favorecendo a sensação de segurança e acolhimento diante das incertezas relacionadas ao desenvolvimento do recém-nascido prematuro. As relações face a face estabelecidas com os profissionais possibilitam a troca contínua de informações, o esclarecimento de dúvidas e a detecção precoce de agravos,

contribuindo para a construção de um cuidado longitudinal, compartilhado e centrado na família (Schütz, 2012).

Entretanto, a vivência da continuidade do cuidado também revela fragilidades estruturais do sistema de saúde, expressas pela dificuldade de acesso a especialidades, longos tempos de espera e necessidade de deslocamentos frequentes, especialmente em região de fronteira. (Zaslavsky; Goulart, 2017). Tais limitações impõem aos genitores a responsabilidade de articular, por iniciativa própria, estratégias para garantir o seguimento assistencial, como a busca por profissionais de referência ou a complementação do cuidado por meio de serviços privados. Tais ações evidenciam a intencionalidade da prática social dos genitores, orientada pelos “motivos para” relacionados à promoção da saúde e do desenvolvimento do(a) filho(a), ainda que isso implique sobrecarga emocional, financeira e logística (Caldeira *et al.*, 2025).

Assim, a continuidade do cuidado configura-se como uma experiência intersubjetiva e situada, na qual os genitores transitam entre a confiança nos serviços de referência e a vivência de vulnerabilidades decorrentes das desigualdades de acesso. A alta hospitalar, embora represente avanço clínico, inaugura uma nova etapa do cuidado, exigindo reorganização constante dos projetos biográficos e familiares. Compreender essa experiência à luz da Fenomenologia Social permite evidenciar que o cuidado ao recém-nascido prematuro se constrói para além das instituições, no cotidiano e nas relações sociais, reforçando a necessidade de práticas e políticas públicas que assegurem a articulação efetiva entre os níveis de atenção à saúde, especialmente em contextos territoriais de fronteira (Schütz, 2008).

A análise dos “Motivos para”, na Categoria 5, evidencia que as expectativas futuras dos genitores estão fortemente orientadas para o cuidado e o desenvolvimento do(a) filho(a), frequentemente em detrimento dos próprios projetos pessoais. A centralidade do bebê na reorganização da vida cotidiana revela uma reconfiguração dos projetos biográficos, em que o “eu” cede lugar a um “nós” estruturado em torno da parentalidade (Schütz, 2012). Ainda assim, observa-se, em alguns relatos, a tentativa de retomar gradualmente projetos individuais, como o retorno ao trabalho e aos estudos, indicando processos de adaptação e reconstrução da identidade após a experiência da prematuridade.

A Categoria “6. *Expectativas em relação ao futuro do filho(a)*” refletem simultaneamente esperança e apreensão, especialmente nos casos em que há diagnóstico de condições crônicas ou sequelas. Os genitores constroem seus projetos a partir das

possibilidades concretas percebidas no presente, articulando cuidados especializados, estímulos cotidianos e acompanhamento em saúde como estratégias para favorecer o desenvolvimento da criança. Esses projetos futuros evidenciam a intencionalidade da ação parental, orientada pela busca de qualidade de vida e inclusão social para o(a) filho(a) (Schütz, 2009).

Dessa forma, a Fenomenologia Social de Alfred Schütz mostrou-se um referencial metodológico robusto para compreender as vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros em região de fronteira, ao permitir a apreensão dos sentidos atribuídos às experiências vividas, às relações sociais estabelecidas e aos projetos orientados para o futuro. Os achados reforçam a necessidade de práticas de cuidado que considerem o mundo da vida dos genitores, reconhecendo suas singularidades, vulnerabilidades e contextos territoriais, especialmente em regiões marcadas por desigualdades sociais e fluxos transfronteiriços.

Por fim, a discussão aponta para a importância da articulação entre atenção hospitalar e atenção ambulatorial, com estratégias que favoreçam a continuidade do cuidado, o acolhimento emocional e o fortalecimento das redes de apoio. Ao compreender as vivências dos genitores para além da dimensão biomédica, o estudo contribui para o aprimoramento das políticas públicas e das práticas em saúde voltadas ao cuidado integral do recém-nascido prematuro e de sua família em contextos de fronteira.

CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou compreender, à luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, as vivências de genitores de recém-nascidos prematuros desde a internação em UTIN até a continuidade do cuidado em saúde em uma região de fronteira. As experiências concretas, relacionadas aos “motivos porque” revelaram-se complexas, atravessadas por intenso sofrimento emocional, rupturas de projetos biográficos, ressignificações subjetivas e reorganizações profundas no cotidiano familiar, evidenciando que a prematuridade ultrapassa a dimensão clínica e se inscreve de forma duradoura no mundo da vida desses genitores.

Os achados demonstraram que a UTIN, inicialmente significada como um espaço de medo, perda e incerteza, foi progressivamente ressignificada a partir das relações intersubjetivas estabelecidas com a equipe de saúde, especialmente quando permeadas por acolhimento, comunicação clara e tecnologias leves de cuidado. Ainda assim, a experiência

da hospitalização esteve fortemente associada à frustração de idealizações acerca da gestação, do parto e da parentalidade, configurando processos de luto simbólico que exigiram reelaboração contínua dos sentidos atribuídos ao ser mãe e pai de um bebê prematuro.

A construção do vínculo parental mostrou-se possível, embora marcada por limites impostos pelo ambiente da UTIN e pelas normas institucionais, assumindo formas singulares mediadas pela presença, pela fala, pelo toque permitido e pela confiança na equipe. No campo emocional, destacaram-se vivências de ansiedade, medo, culpa, tristeza e exaustão, potencializadas em casos de histórico prévio de sofrimento psíquico, o que reforça a centralidade do cuidado em saúde mental aos genitores ao longo de todo o processo.

As redes de apoio — familiares, conjugais, institucionais e religiosas — emergiram como elementos fundamentais para o enfrentamento da prematuridade, especialmente em contexto de fronteira, no qual o afastamento do território de origem, a precariedade socioeconômica e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde intensificam as vulnerabilidades vividas. A continuidade do cuidado após a alta hospitalar foi compreendida como uma extensão da experiência da UTIN, marcada por ambivalência entre alívio e insegurança, exigindo dos genitores protagonismo na articulação dos serviços e reorganização permanente de suas rotinas e projetos de vida.

No que se refere aos “motivos para”, as expectativas futuras mostraram-se fortemente orientadas para o cuidado e o desenvolvimento do filho, frequentemente em detrimento dos projetos pessoais, evidenciando a centralidade da parentalidade na reorganização biográfica desses sujeitos. Ainda assim, alguns genitores sinalizaram movimentos graduais de retomada de projetos individuais, indicando processos de adaptação e reconstrução identitária após a experiência da prematuridade.

Como contribuição, este estudo amplia o conhecimento no campo da Saúde Coletiva ao evidenciar as especificidades das vivências de genitores de prematuros em regiões de fronteira, destacando a necessidade de políticas públicas e práticas de cuidado que considerem as singularidades territoriais, sociais e culturais desses contextos. Ressalta-se a importância da articulação efetiva entre os níveis de atenção à saúde, do fortalecimento dos serviços de seguimento ambulatorial e da inclusão sistemática do cuidado psicológico aos genitores, desde a internação até o pós-alta.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o delineamento transversal, que não permite acompanhar as transformações das vivências parentais ao longo do tempo. No entanto, a

abordagem qualitativa fundamentada na Fenomenologia Social possibilitou uma compreensão aprofundada e situada das experiências dos genitores no contexto da prematuridade. Sugere-se a realização de estudos longitudinais e comparativos, que permitam acompanhar essas vivências em diferentes momentos do percurso assistencial e em distintos contextos territoriais, incluindo outras regiões de fronteira.

Por fim, compreender a prematuridade a partir do mundo da vida dos genitores possibilita reconhecer que o cuidado ao recém-nascido prematuro é um processo contínuo, intersubjetivo e compartilhado, que demanda sensibilidade, escuta qualificada e políticas de saúde comprometidas com a integralidade do cuidado ao bebê e à sua família.

REFERÊNCIAS:

- ACOSTA, M. CABRERA, N. Percepción de padres de hijos prematuros frente a la hospitalización en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal: un estudio de revisión documental. **Revista UNIMAR**, v. 34, n.1, p. 193-199, 2016. Disponível em: <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1144>. Acesso em: 06 jun. 2013.
- ANDRADE, C. J.; BACCELLI, M. S.; BENINCASA, M. O vínculo mãe-bebê no período de puerpério: uma análise winnicottiana. **Vínculo**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 1-13, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-24902017000100004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 10 jun. 2023.
- BASEGGIO, D. B. *et al.*. Vivências de mães e bebês prematuros durante a internação neonatal. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 25, n. 1, p. 153-167, mar. 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2017000100010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 jun. 2023. <http://dx.doi.org/10.9788/TP2017.1-10>.
- BESSA, M. M. *et al.* A fenomenologia de Alfred Schütz e sua aplicação no campo da pesquisa em saúde e enfermagem. **Revista Sustinere**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 842–857, 2023. DOI: 10.12957/sustinere.2023.72222. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/72222>. Acesso em: 19 jan. 2026.
- BRASIL. Ministério da Educação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. **Rede Cegonha**. Salvador, BA, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha>. Acesso em: 02 nov. 2024.
- _____. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). **Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/>. Acesso em: 09 jan. 2026.

BRASSAROLA, H. G. M.; NATARELLI, T. R. P.; FONSECA, L. M. M. Uso do grupo de WhatsApp no acompanhamento pós-alta do bebê prematuro: implicações para o cuidado em enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 27, p. 1-9, jun./set. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/4gM3GgjbBHHdVdXVYB4FSdL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 out. de 2024.

CALDEIRA, S. *et al.* Perspectivas de homens autores de violência intrafamiliar em fronteira internacional. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 17, n. 5, p. 1-18, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/8500>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CAPALBO, C. **Fenomenologia e Ciências Humanas**. 1. Ed. São Paulo: Idéias & Letras, 2008.

CASTRO, A. S. V. P.; GERMANO, I. L.; FERREIRA, T. H. Os aspectos psicológicos da mulher: da gravidez ao puerpério. **CES Revista**, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 202-218, dez. 2019. ISSN 1983-1625. Disponível em: <https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cesRevista/article/view/2286/1513>. Acesso em: 16 out. 2023.

CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL. **Sobre o Cenni**, 2024. Disponível em: https://www.centrodenutricao.org.br/?page_id=133. Acesso em: 12 out. 2024.

COELHO, M. O.; JORGE, M. S. B.. Tecnologia das relações como dispositivo do atendimento humanizado na atenção básica à saúde na perspectiva do acesso, do acolhimento e do vínculo. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 14, p. 1523–1531, set. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/F8cMBSY8RtNZw3349gRrLqR/?format=pdf&lang=pt#>. Acesso em: 10 jun. 2023.

CRUZ DANTAS, M. M. *et al.*. Mães de recém-nascidos prematuros e a termo hospitalizados: avaliação do apoio social e da sintomatologia ansiogênica. **Act.Colom.Psicol.**, Bogotá , v. 18, n. 2, p. 129-138, July 2015 . Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552015000200011&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 22 out. de 2023.

ESTEVES, C.M. *et al.*. “É um Bombardeio de Sentimentos”: Experiências Maternas no Contexto do Nascimento Prematuro. **Psico - USF**, v. 28, n. 1, p. 53-66, jan./mar. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/MyYXjZKbLc9KgBCJ3VxXscz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. de 2023.

FLEK, J. A. *et al.*. Da perda ao bebê arco-íris: uma jornada de luto e perseverança. **Revista Delos**, [S. l.], v. 18, n. 66, p. 1-15, nov. 2025. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/4724>. Acesso em: 08 jan. 2026.

FOZ DO IGUAÇU (Cidade). “**Terra das Cataratas**”. Sobre a cidade. Foz do Iguaçu, 2020. Disponível em: <<https://www5.pmf.pr.gov.br/cidade/#>>. Acesso em: 15 de out. 2024.

GIGUER, F. F.; SILVA, M. R. Uma Travessia no Contexto da Prematuridade: da Uti-Neonatal até a Casa. **Psicologia em Estudo**, v. 29, p. 1-14, abr. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/PVksjVX8BtdwwwjqcbgMh9m/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2024.

HIRANO, A. R. *et al.*. Continuidade do cuidado da criança na Atenção Primária à Saúde em região de fronteira. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 27, p. 1-17, Jan./maio 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/8JRNdR3swtdQYRVsfwqmHjN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 8 nov. 2024.

HORTELAN, M. S. *et al.*. Papel do gestor de saúde pública em região de fronteira: scoping review. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, n. 2, p. 229–236, mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/tt3Y6pqFfw5b8KrymRVmBYb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 nov. 2024.

MINAYO, M. C. S. **O Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 15. ed. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 2025.

NEVES, P. N., RAVELLI, A. P. X., LEMOS, J. R. D. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-peso (método mãe canguru): percepções de puérperas. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, 31(1), 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v31n1/a07v31n1.pdf>, Acesso em: 10 jun. 2023.

SCHÜTZ, A. **El problema de la realidad social**. Tradução de Néstor Míguez, Buenos Aires: Amorrortu, 2008.

_____. **Las estructuras del mundo de la vida**. Tradução de Néstor Míguez, Buenos Aires: Amorrortu, 2009.

_____. Sobre **Fenomenologia e Relações Sociais**. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

SILVA, V. R.; UGOSKI, D. R.; DRAVANZ, G. M. G. Negação de Direitos Socioassistenciais para Transfronteiriços Indocumentados: desafios para as cidades gêmeas. **Textos & Contextos**, v. 16, n. 1, p. 231–243, jan./jul. 2017. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/27121/15754>. Acesso em: 18 out. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION & UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND. Survive and thrive: transforming care for every small and sick newborn. Disponível em: https://reliefweb.int/report/world/survive-and-thrive-transforming-care-every-small-and-sick-newborn?gclid=CjwKCAiAjPyfBhBMEiwAB2CCIgJ4bLD8KziI3FJ-DilWKmSNDR96I6zgU0ORb0OUyMBap9uSORXcTBoC-nUQAvD_BwE, Genebra, 2018. Acesso em: 12 jun. 2023.

ZANFOLIM, L. C.; CERCHIARI, E. A. N.; GANASSIN, F. M. H. Dificuldades Vivenciadas pelas Mães na Hospitalização de seus Bebês em Unidades Neonatais.

Psicologia: Ciência e Profissão, v. 38, n. 1, p. 22–35, jan. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/xKpVCkhpQLgm8bPqRSZZ97L/?lang=pt#>. Acesso em: 10 jun. 2023.

ZASLAVSKY, R.; GOULART, B. N. G. Migração pendular e atenção à saúde na região de fronteira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 12, p. 3981–3986, fev./jun. 2017.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/qmqyF5sw58GvC7qBCrpS4Hn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 nov. 2024.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou compreender a vivência de genitores de recém-nascidos prematuros no percurso entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e a continuidade do cuidado em saúde em uma região de fronteira, tomando como base a Fenomenologia Social de Alfred Schütz. Esse referencial possibilitou acessar os sentidos atribuídos às experiências vividas, a partir das relações intersubjetivas estabelecidas ao longo do cuidado e das expectativas construídas pelos genitores em seu mundo da vida cotidiana.

Os achados evidenciaram que a prematuridade foi vivenciada como um evento de ruptura, marcado por intenso sofrimento emocional, medo, insegurança e profundas alterações no cotidiano familiar. A hospitalização em UTIN impôs limites à participação parental e confrontou os genitores com um ambiente altamente tecnificado, frequentemente percebido como hostil e gerador de sentimento de impotência. Ao mesmo tempo, esse espaço foi reconhecido como fundamental para a sobrevivência do recém-nascido, revelando a ambivalência presente nas vivências parentais durante a internação.

No enfrentamento desse contexto, os genitores mobilizaram diferentes estratégias, como o apoio familiar, a fé, a troca de experiências com outros pais e mães e o vínculo construído com os profissionais de saúde. Tais recursos mostraram-se essenciais para a sustentação emocional ao longo da hospitalização e no período subsequente à alta, contribuindo para a resignificação da experiência da prematuridade e para o fortalecimento da parentalidade frente às demandas do cuidado ao recém-nascido pré-termo.

As práticas desenvolvidas pela equipe de saúde neonatal exerceram influência significativa na forma como os genitores significaram o cuidado recebido. Acolhimento, escuta qualificada, comunicação clara e inclusão dos familiares no processo de cuidado emergiram como elementos centrais para a construção de confiança, para o enfrentamento do sofrimento e para o fortalecimento do vínculo com o bebê. Em contrapartida, fragilidades nas interações e na comunicação foram associadas a sentimentos de insegurança e distanciamento, reforçando a importância das tecnologias leves no cuidado neonatal.

A continuidade do cuidado após a alta hospitalar foi marcada por sentimentos ambíguos, nos quais a alegria pela sobrevivência do recém-nascido coexistiu com o medo e a insegurança diante das responsabilidades do cuidado domiciliar. O seguimento especializado

no Centro de Nutrição Infantil configurou-se como importante rede de apoio técnico e emocional, favorecendo a construção de segurança, aprendizado e autonomia dos genitores no cuidado cotidiano.

O contexto de fronteira acrescentou especificidades às vivências parentais, evidenciadas pelas dificuldades de deslocamento, pelo afastamento dos territórios de origem e pelas diferenças socioculturais. Esses aspectos reforçam a necessidade de práticas de cuidado sensíveis às singularidades territoriais, que considerem não apenas as demandas clínicas do recém-nascido, mas também as condições sociais e subjetivas das famílias.

Sendo assim, a compreensão das vivências dos genitores, à luz da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, evidencia que o cuidado ao recém-nascido prematuro ultrapassa a dimensão biológica, exigindo atenção às experiências subjetivas e às relações intersubjetivas construídas ao longo do processo de cuidado. Os resultados deste estudo oferecem subsídios para o aprimoramento das práticas de cuidado humanizado, para a qualificação da atuação das equipes de saúde neonatal e para o fortalecimento de políticas públicas que promovam a integralidade da assistência ao recém-nascido prematuro e à sua família, especialmente em regiões de fronteira.

REFERÊNCIAS:

- ACOSTA, M. CABRERA, N. Percepción de padres de hijos prematuros frente a la hospitalización en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal: un estudio de revisión documental. **Revista UNIMAR**, v. 34, n.1, p. 193-199, 2016. Disponível em: <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1144>. Acesso em: 06 jun. 2013.
- ANDRADE, A. C. A Cidade Média nas Três Fronteiras - Dinâmicas socioespaciais em Foz do Iguaçu (PR). **Rev. Geografia**, v. 31, n. 1, p. 157–177, jan. 2022. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/43773>. Acesso em: 20 out. 2024.
- ANDRADE, C. J.; BACCELLI, M. S.; BENINCASA, M. O vínculo mãe-bebê no período de puerpério: uma análise winnicottiana. **Vínculo**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 1-13, 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-24902017000100004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 10 jun. 2023.
- ARAGÃO, R. O. D. **A construção do espaço psíquico materno e seus efeitos sobre o psiquismo nascente do bebê**. 2007. 120f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
- BADINTER, E. **O conflito: a mulher e a mãe**. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.
- BAILER, C.; TOMITCH, L. M. B.; D'ELY, R. C. S. F. O Planejamento Como Processo Dinâmico: A Importância do Estudo Piloto Para Uma Pesquisa Experimental em Linguística Aplicada. **Intercâmbio**, v. 24, [S. N.], p. 129-146, 2011. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/10118>. Acesso em: 01 nov. 2024.
- BASEGGIO, D. B. *et al.*. Vivências de mães e bebês prematuros durante a internação neonatal. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 25, n. 1, p. 153-167, mar. 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2017000100010&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 19 jun. 2023. <http://dx.doi.org/10.9788/TP2017.1-10>.
- BERRES, R.; BAGGIO, M. A. (Dis) continuidade do cuidado ao recém-nascido pré-termo em região de fronteira. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 3, p. 1-8, out./mar. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/MS799NsJTM79MxDYbV8XKZR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 de out. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. **Rede Cegonha**. Salvador, BA, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha>. Acesso em: 02 nov. 2024.
- _____. Ministério da Saúde. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. **ANS alerta gestantes para o Dia Mundial da Prematuridade**. Brasília, 2022. Disponível em:

<https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-alerta-gestantes-para-o-dia-mundial-da-prematuridade>. Acesso em: 13 out. 2023.

_____. Ministério da Saúde. **Governo Federal lança nova estratégia para reduzir mortalidade materna em 25 % até 2027**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/governo-federal-lanca-nova-estrategia-para-reduzir-mortalidade-materna-em-25-ate-2027#:~:text=Garantia%20de%20um%20cuidado%20integral,na%20rede%20p%C3%BAblica%20de%20sa%C3%BAde>. Acesso em: 08 nov. 2024.

_____. Ministério da Saúde. **Ressolução nº 466, 12 de dezembro de 2012**. Brasília, 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>. Acesso em: 15 out. 2024.

_____. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). **Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/>. Acesso em: 09 jan. 2026.

BRASSAROLA, H. G. M.; NATARELLI, T. R. P.; FONSECA, L. M. M. Uso do grupo de WhatsApp no acompanhamento pós-alta do bebê prematuro: implicações para o cuidado em enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 27, p. 1-9, jun./set. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/4gM3GgjgBHHdVdXVYB4FSdL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 out. de 2024.

CALDEIRA, S. *et al.* Perspectivas de homens autores de violência intrafamiliar em fronteira internacional. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 17, n. 5, p. 1-18, 2025. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/8500>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CAMARGO, K. G. *et al.* Desempenho Motor de Lactentes Prematuros Egressos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e sua Associação com o Tempo Pós-Alta Hospitalar. **Rev. Movimenta** - UEG, v. 16, n. 3, p. 1-15, fev./set. 2023. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta/article/view/13736/10151>. Acesso em: 08 de nov. 2024.

CAPALBO, C. **Fenomenologia e Ciências Humanas**. 1. Ed. São Paulo: Idéias & Letras, 2008.

CARVALHO, L.S.; PEREIRA, C. M. C. As reações psicológicas dos pais frente à hospitalização do bebê prematuro na UTI neonatal. **Rev. SBPH**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 101-122, dez. 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582017000200007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 19 jun. 2023.

CASTRO, A. S. V. P.; GERMANO, I. L.; FERREIRA, T. H. Os aspectos psicológicos da mulher: da gravidez ao puerpério. **CES Revista**, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 202-218, dez. 2019.

ISSN 1983-1625. Disponível em:

<https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cesRevista/article/view/2286/1513>. Acesso em: 16 out. 2023.

CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL. **Sobre o Cenni**, 2024. Disponível em:

https://www.centrodenutricao.org.br/?page_id=133. Acesso em: 12 out. 2024.

COELHO, M. O.; JORGE, M. S. B.. Tecnologia das relações como dispositivo do atendimento humanizado na atenção básica à saúde na perspectiva do acesso, do acolhimento e do vínculo. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 14, p. 1523–1531, set. 2009.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/F8cMBSY8RtNZw3349gRrLqR/?format=pdf&lang=pt#>.

Acesso em: 10 jun. 2023.

CRUZ DANTAS, M. M. *et al.*. Mães de recém-nascidos prematuros e a termo hospitalizados: avaliação do apoio social e da sintomatologia

ansiosígenica. **Act.Colom.Psicol.**, Bogotá, v. 18, n. 2, p. 129-138, July 2015. Disponível

em: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552015000200011&lng=en&nrm=iso)

91552015000200011&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 22 out. de 2023.

ESTEVAM, D. C. M.; SILVA, J. D. D. Visão das Mães em Relação ao Cuidado com o

Recém-Nascido após a Alta da Uti Neonatal. **Saúde e Pesquisa – Rev. Saúde e pesquisa**, v. 9 n. 1, p. 15-24, jan./abr. 2016. Disponível em:

<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/4161/2745>. Acesso

em: 01 nov. de 2024.

ESTEVEZ, C.M. *et al.*. “É um Bombardeio de Sentimentos”: Experiências Maternas no Contexto do Nascimento Prematuro. **Psico - USF**, v. 28, n. 1, p. 53-66, jan./mar. 2023.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pusf/a/MyYXjZKbLc9KgBCJ3VxXscz/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 10 jun. de 2023.

FERRARI, A. G.; PICCININI, C. A.; LOPES, R. S.. O bebê imaginado na gestação:

aspectos teóricos e empíricos. **Psicologia em Estudo**, v. 12, n. 2, p. 305–313, maio 2007.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/XFyR94p8sZdPzLBzmwrZXqd/?lang=pt#>.

Acesso em 09 jun. 2023.

FORMIGA, C. K. M. R.; SILVA, L. P.; LINHARES, M. B. M. Identificação de fatores de risco em bebês participantes de um programa de Follow-up. **Revista CEFAC**, v. 20, n. 3, p. 333–341, maio/jun. 2018. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rcefac/a/r6cdyqGBnR49KTjmBKGZqby/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 04 nov. 2024.

Foz do Iguaçu (Cidade). (2020). *Terra das Cataratas: Sobre a cidade*.

<https://www5.pmfi.pr.gov.br/cidade/#>

FREITAG, R. M. K. Amostras Sociolinguísticas: probabilísticas ou por conveniência?.

Revista de Estudos da Linguagem, v. 26, n. 2, p. 667-686, set./out. 2018. Disponível em:

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/12412>. Acesso em: 10

out. 2024.

FREITAS, R. J. M.; MOURA, N. A. MONTEIRO, A. R. M. Violência contra crianças/adolescentes em sofrimento psíquico e cuidado de enfermagem: reflexões da fenomenologia social. **Rev. Gaúcha Enfermagem**, v. 37, n. 1, p. 1-4, mar. 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2016.01.52887>. Acesso em: 17 out. 2024.

FREUD, S. Conferência XXXII: ansiedade e vida instintual, 1932. In: _____. **Novas conferências introdutórias sobre psicanálise (Vol. 22)**. Rio de Janeiro: Imago, 2010. p. 85-112. ((Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud).

GALLEGOS-MARTINEZ, J.; REYES-HERNANDEZ, J.; SCOCHI, C. G. S. O neonato prematuro hospitalizado: significado da participação na Unidade Neonatal para os pais. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S. l.], v. 21, n. 6, p. 1360-1366, 2013. DOI: 10.1590/0104-1169.2970.2375. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/76061>. Acesso em: 16 jun. 2023.

GIGUER, F. F.; SILVA, M. R. Uma Travessia no Contexto da Prematuridade: da Uti-Neonatal até a Casa. **Psicologia em Estudo**, v. 29, p. 1-14, abr. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/PVksjVX8BtdwwwjqcbgMh9m/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2024.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2022.

GIOVANELLA, L. *et al.*. Saúde nas fronteiras: acesso e demandas de estrangeiros e brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL na perspectiva dos secretários municipais de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, n. 2, p. 251-266, mar./maio 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/c3dJ5WtjKZZw5JyvVCN93fB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 05 nov. 2024.

HAHN, C. N. G. **Impacto da idealização da maternidade no psiquismo da mulher: uma perspectiva psicanalítica**. 2022. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, Santa Catarina.

HIRANO, A. R. *et al.*. Continuidade do cuidado da criança na Atenção Primária à Saúde em região de fronteira. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 27, p. 1-17, Jan./maio 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/8JRNdR3swtdQYRVsfwqmHjN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 8 nov. 2024.

HORTELAN, M. S. *et al.*. Papel do gestor de saúde pública em região de fronteira: scoping review. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 32, n. 2, p. 229–236, mar. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/tt3Y6pqFfw5b8KrymRVmBYb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 nov. 2024.

JESUS, M. C. P. *et al.*. A fenomenologia social de Alfred Schütz e sua contribuição para a enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 47, n. 3, p. 736–741, jun.

2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/hLcpxVjMwdJC74hNhqfTVNg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 nov. 2024.

JUNG, C. A. **A vida simbólica**. Tradução de Araceli Elman, Edgar Orth, Rio de Janeiro: Vozes, 2015.

LASTE, N. B. *et al.*. Seguimento do recém-nascido prematuro na Atenção Básica. **Lumen Et Virtus**. v. 15, n. 39, p. 2057-2077, ago. 2024. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/182/316>. Acesso em: 01 nov. 2024.

LEBOVICI, S. **O bebê, a mãe e o psicanalista**. 1. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.

LEMO, T. M. F.; FARIA, H. M. C. O impacto Emocional em Mães de Prematuros. **Cadernos de Psicologia**. v. 6, n. 11, p. 492-507, jul. 2024. Disponível em: <https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cadernospsicologia/article/view/4139/3077>. Acesso em: 01 nov. 2024.

MARCHETTI, D.; MOREIRA, M. C. Vivências da prematuridade: a aceitação do filho real pressupõe a desconstrução do bebê imaginário?. **Revista Psicologia e Saúde**, [S. l.], v. 7, n. 1, 2015. DOI: 10.20435/pssa.v7i1.408. Disponível em: <https://www.pssa.ucdb.br/pssa/article/view/408>. Acesso em: 12 jun. 2023.

MATHELIN, C. **O sorriso de Gioconda**: Clínica psicanalítica com os bebês prematuros. 1. ed. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1999.

MELLO, F.; VICTORA, C. G.; GONÇALVES, H. Saúde nas fronteiras: análise quantitativa e qualitativa da clientela do Centro Materno Infantil de Foz do Iguaçu, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 20, n. 7, p. 2135-2145, jul./mar. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2015.v20n7/2135-2145/pt>. Acesso em: 07 nov. 2024.

MINAYO, M. C. S. **O Desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 15. ed. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 2025.

NEVES, P. N., RAVELLI, A. P. X., LEMOS, J. R. D. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-peso (método mãe canguru): percepções de puérperas. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, 31(1), 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v31n1/a07v31n1.pdf>, Acesso em: 10 jun. 2023.

QUEIROZ, M. A. S. *et al.*. Tecnologias eHealth nos cuidados parentais aos bebês nascidos prematuros: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 8, p. 1-11, ago. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qFr7SPZMv8nYVW5pCMn97Lh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 04 nov. 2024.

REZENDE TAVARES, G. MOTA, J. A. C.; MAGRO, C. Visão sistêmica da prematuridade: as interações entre família e equipe de saúde diante do recém-nascido pré-termo em UTI neonatal. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 24, n. 1, março, 2006, p. 27-34.

Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4060/406038915005.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2023.

SANTOS FILHO, S. B.; SOUZA, K. V. Rede Cegonha e desafios metodológicos de implementação de redes no SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 26, n. 3, p. 775-780, mar. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2021.v26n3/775-780/pt>. Acesso em: 02 nov. 2024.

SCHÜTZ, A. **El problema de la realidad social**. Tradução de Néstor Míguez, Buenos Aires: Amorrortu, 2008.

_____. **Fenomenologia e Relações Sociais**. Tradução de Ângela Melin, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.

_____. **Las estructuras del mundo de la vida**. Tradução de Néstor Míguez, Buenos Aires: Amorrortu, 2009.

_____. Sobre **Fenomenologia e Relações Sociais**. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan. **A humanização da assistência hospitalar ao bebê prematuro**: bases teóricas para o cuidado de enfermagem. 2001. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2001. Acesso em: 17 jun. 2023.

SEIXAS, C. T. *et al.* A crise como potência: os cuidados de proximidade e a epidemia pela COVID-19. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 25, n. 1, e200379, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.200379>. Acesso em: 10 out. 2023.

SERGIPE (Estado). Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. **Follow-up acompanha prematuros antes e após saída da MNSL**, 2020. Disponível em: <https://saude.se.gov.br/follow-up-acompanha-prematuros-antes-e-apos-saida-da-mnsl/#:~:text=Para%20quem%20n%C3%A3o%20conhece%2C%20o,interven%C3%A7%C3%A3o%20imediate%2C%20caso%20seja%20necess%C3%A1rio>. Acesso em: 14 out. 2024.

SILVA, V. R.; UGOSKI, D. R.; DRAVANZ, G. M. G. Negação de Direitos Socioassistenciais para Transfronteiriços Indocumentados: desafios para as cidades gêmeas. **Textos & Contextos**, v. 16, n. 1, p. 231–243, jan./jul. 2017. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/article/view/27121/15754>. Acesso em: 18 out. 2024.

SOLER, C. **O que Lacan dizia das mulheres**. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

SOUZA, M. N. C. Algumas Considerações Sobre a Sociologia de Alfred Schütz. **Em Tese** – Revista Eletrônica dos Pós Graduados em Sociologia Política da UFSC, Bahia, v. 9, n. 1, p. 1-26, jan./jul. 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/1806-5023.2012v9n1p1/23492>. Acesso em: 04 nov. 2024.

STERN, D.N; BRUSCHWEILER-STERN, N; FREELAND, A. El nacimiento de una madre cómo la experiencia de la maternidad te cambia la vida para siempre. **Rev. de psicoanálisis**. v. 1, n. 44, 2013. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6466444>. Acesso em: 05 jun. 2023.

TERRA, M. G. *et al.*. Na trilha da fenomenologia: um caminho para a pesquisa em enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 15, n. 4, p. 672–678, out. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/y5SXYgj5pqcDkQ739y6cH6j/?lang=pt#>. Acesso em: 10 out. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION & UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. Survive and thrive: transforming care for every small and sick newborn. Disponível em: https://reliefweb.int/report/world/survive-and-thrive-transforming-care-every-small-and-sick-newborn?gclid=CjwKCAiAjPyfBhBMEiwAB2CCIgJ4bLD8KziI3FJDilWKmSNDR96I6zgU0ORb0OUyMBap9uSORXcTBoC-nUQAvD_BwE, Genebra, 2018. Acesso em: 12 jun. 2023.

XAVIER, J. S.; BERNARDINO, F. B. S.; GAÍVA, M. A. M. Seguimento do recém-nascido de risco: revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. 1-19, out./nov. 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9515/8527>. Acesso em: 20 out. 2024.

ZANFOLIM, L. C.; CERCHIARI, E. A. N.; GANASSIN, F. M. H. Dificuldades Vivenciadas pelas Mães na Hospitalização de seus Bebês em Unidades Neonatais. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 38, n. 1, p. 22–35, jan. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/xKpVCkhpQLgm8bPqRSZZ97L/?lang=pt#>. Acesso em: 10 jun. 2023.

ZASLAVSKY, R.; GOULART, B. N. G. Migração pendular e atenção à saúde na região de fronteira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 12, p. 3981–3986, fev./jun. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/qmqyF5sw58GvC7qBCrpS4Hn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 nov. 2024.

APÊNDICES

APÊNDICE A



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP

Pesquisador principal: Elyabe Rodrigues
elyabe@udc.edu.br

Mestrando em Saúde Pública em Região de fronteira – UNIOESTE
Psicólogo



Aprovado na

CONEP em 04/08/2000

e-mail:

Telefone: 45 999733296

Profissão:

CRP: 08/30830

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre as “**Vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros em região de fronteira: Da internação em UTI Neonatal à continuidade do cuidado em saúde**”. O objetivo é compreender as experiências de genitores de recém-nascidos prematuros vivos entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira e têm o propósito de fornecer subsídios para elaboração de planos, protocolos e políticas de humanização do cuidado aos genitores e recém-nascidos prematuros, na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

O presente estudo apresenta riscos mínimos, sendo estes possíveis constrangimentos, desconfortos ou ansiedade por parte do entrevistado. Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Também você poderá a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

Sua participação na pesquisa ocorrerá por meio da concessão de entrevista individual, gravada em gravador digital de voz, resguardando a sua identidade. A entrevista ocorrerá de modo presencial, agendada conforme o local e o dia mais viável para você. Em período prévio ao início da entrevista, será lido o presente termo e assinado. Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo, no entanto, terá direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem nunca serão associados aos resultados desta pesquisa, exceto quando você desejar. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, específico para essa autorização e que deverá ser apresentado separadamente deste.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso.

Este documento que você vai assinar contém 2 páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada no cartório (caso tenha). Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 12h30 as 17h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 – Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092 e (45) 99113-1149 – WhatsApp.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento.

Nome do participante da pesquisa ou responsável:

Assinatura:

Eu, *Elyabe Rodrigues*, declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante.

Assinatura do pesquisador

Foz do Iguaçu, _____ de _____ de 2025.

APÊNDICE B

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Data entrevista: ____/____/____
Identificação do participante: ____
Ordem de entrevista: ____

Caracterização sociodemográfica dos participantes

Identidade Racial: ____
Sexo: () Feminino () Masculino
Idade: ____
Estado civil: ____
Nacionalidade: ____
País e cidade de residência atual: ____
Quantidade de filhos: ____
Quantidade de filhos prematuros: ____
Quantidade de filhos que passaram por internação em Unidade de Terapia Intensiva: ____
Quantidade de filhos que realizam ou realizaram a continuidade do cuidado no Centro de Nutrição Infantil (CENNI): ____

Formação:

Qual é o seu grau de escolaridade? () Sem escolaridade () Fundamental incompleto () Fundamental completo () Médio incompleto () Médio completo () Superior incompleto () Superior completo

Área de formação: ____
Ano de formação na graduação: ____
Pós-Graduação: () Especialização () Mestrado () Doutorado.
Área(s): ____
Ano que findou pós-graduação: ____

Roteiro de entrevista:

Motivos porque:

- 1) Conte-me sobre a idealização e planejamento relacionado a seu bebê antes do nascimento;
- 2) Conte-me como percebeu/percebe o cuidado profissional com o seu bebê e com você na UTI Neonatal;

- 3) Relate-me sobre suas percepções ao entrar pela primeira vez em uma UTI Neonatal e a influência da internação neste espaço para a formação de vínculo entre mãe-bebê / pai-bebê;
- 4) Como está sendo para você a continuidade do cuidado com o seu bebê e com você no CENNI?

Motivos para:

- 1) O que espera para o seu/sua filho/filha de agora em diante?
- 2) O que espera para você?
- 3) Quais as suas expectativas em relação à equipe de saúde nos cuidados aos bebês e aos genitores de bebês prematuros na UTI Neonatal?
- 4) E o que espera por parte dos profissionais do CENNI para o seu bebê e para você?
- 5) Gostaria de falar sobre algo que não perguntei nesta entrevista?

APÊNDICE C

**Solicitação de Autorização para a Pesquisa****UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE – PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE FRONTEIRA - MESTRADO**

Foz do Iguaçu PR, 20 de janeiro de 2025.

Ao Centro de Nutrição Infantil (CENNI), Foz do Iguaçu PR.

Solicitamos a vossa autorização, para a realização da coleta de dados por meio de entrevista gravadas presenciais, junto aos genitores de pacientes prematuros de até 2 anos de idade que são atendidos na instituição, localizada no município de Foz do Iguaçu, Brasil, para a pesquisa intitulada: **Vivências dos Genitores de Prematuros: da Internação à Continuidade do Cuidado em Saúde.**

Trata-se de uma pesquisa de dissertação de Mestrado para o Programa de Pós-graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira - Mestrado, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE localizada no município de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, com o objetivo de compreender a vivência de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira;

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas presenciais no período de março a junho de 2025, após obter vossa autorização, o consentimento dos(as) participantes da pesquisa e o parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – CEP/Unioeste.

O número de participantes não será determinado nesse momento, e as entrevistas serão encerradas quando os resultados se mostrarem suficientes, respondendo ao objetivo do estudo e as inquietações do pesquisador.

Espera-se que a partir do desenvolvimento deste estudo se alcance conhecimento e compreensão das vivências dos genitores de recém-nascidos prematuros vivos, que passaram por internação em UTIN e dão seguimento no cuidado no CENNI. Através dos resultados deste estudo, supõe-se que os dados evidenciados forneçam subsídios para elaboração de planos, protocolos e políticas de humanização do cuidado aos genitores e recém-nascidos prematuros, na região de fronteira. Além disso, espera-se que o plano metodológico proposto na pesquisa sirva de modelo para replicação do estudo em outras regiões.

CENTRO DE NUTRICAÇÃO
INFANTIL:8674773000
0176

Assinado de forma digital por
CENTRO DE NUTRICAÇÃO
INFANTIL:86747730000176
Dados: 2025.01.23 15:17:54 -03'00'

Responsável do Centro de Nutrição Infantil (CENNI)

gov.br Documento assinado digitalmente
ELYABE RODRIGUES
Data: 20/01/2025 08:43:47-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Elyabe Rodrigues
Acadêmico

gov.br Documento assinado digitalmente
SEBASTIAO CALDEIRA
Data: 20/01/2025 14:32:53-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Sebastião Caldeira
Orientador

APÊNDICE D



Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Aprovado na

Comitê de Ética em pesquisa – CEP

Em 04/08/2000



CONEP

Anexo I Formulário de pesquisa

Título da pesquisa: Vivências dos Genitores de Prematuros: da Internação à Continuidade do Cuidado em Saúde.

Pesquisador responsável: Dr. Sebastião Caldeira

Pesquisador(es) Assistente(s): Elyabe Rodrigues

Tipo de pesquisa

- | | |
|---|--|
| ☐ Iniciação científica | ☒ Dissertação/Mestrado |
| ☐ TCC – Graduação | ☐ Tese/Doutorado |
| ☐ TCC – Especialização | ☐ Projeto Institucional |

Anexo II Autorização da Instituição Coparticipante

Os pesquisadores Sebastião Caldeira e Elyabe Rodrigues estão autorizados por esta instituição, Centro de Nutrição Infantil (CENNI), a realizar a pesquisa intitulada: Vivências dos Genitores de Prematuros: da Internação à Continuidade do Cuidado em Saúde, assegurando as normas da Resolução 466/12 e/ou 510/16 – CNS/MS e suas complementares.

Declaramos que a coleta de dados nessa instituição Coparticipante será iniciada somente após a aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste (CEP - UNIOESTE).

CENTRO DE NUTRICAÇÃO
INFANTIL:8674773000
0176

Assinado de forma digital por
CENTRO DE NUTRICAÇÃO
INFANTIL:86747730000176
Dados: 2025.01.23 15:19:18 -03'00'

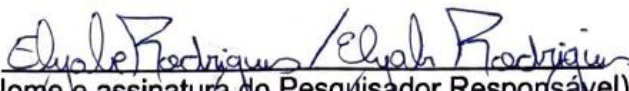
(Assinatura do Responsável do CENNI)

Foz do Iguaçu PR, 20 de janeiro de 2025.

APÊNDICE E**Anexo III
Declaração de uso de Dados****[X] SIM**

O(s) pesquisador(es) abaixo assinado se comprometem a:

1. Garantir a privacidade dos participantes da pesquisa, a guarda segura e o anonimato das informações coletadas;
2. Usar os dados coletados unicamente para esta pesquisa;
3. Detalhar as informações que serão retiradas dos documentos que envolvam as fontes secundárias (quando o método de pesquisa permitir);
4. Respeitar as Resoluções 466/12 e/ou 510/16 CNS/MS e suas complementares


(Nome e assinatura do Pesquisador Responsável)

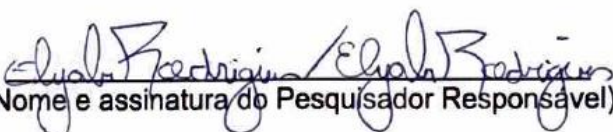
APÊNDICE F

Anexo IV Declaração de Pesquisa não iniciada

Declaramos que essa pesquisa não foi iniciada e aguarda a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Unioeste. Ao término desse estudo, nos comprometemos a tornar público os resultados, promover a devolutiva aos participantes (quando possível) e a apresentar o Relatório Final ao CEP Unioeste (apensado na Plataforma Brasil), até 30 dias após o término da pesquisa.

Declaramos a ciência das implicações legais decorrentes dos descumprimentos dos anexos I a IV.

Foz do Iguaçu PR, 03 de março de 2025.


(Nome e assinatura do Pesquisador Responsável)

ANEXO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: VIVÊNCIAS DOS GENITORES DE PREMATUROS: DA INTERNAÇÃO À CONTINUIDADE DO CUIDADO EM SAÚDE

Pesquisador: ELYABE RODRIGUES

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 87365225.7.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.532.108

Apresentação do Projeto:

Projeto de Dissertação de Mestrado. Estudo tem como objetivo compreender as vivências de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira. Para isto, será realizado

uma pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando-se do referencial teórico e metodológico da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, com aplicação de entrevistas semiestruturadas com genitores de recém-nascidos prematuros que frequentam e recebem assistência no Centro de

Nutrição Infantil, na cidade de Foz do Iguaçu. A partir dos resultados deste estudo, supõe-se que os dados evidenciados forneçam subsídios para elaboração de planos, protocolos e políticas de humanização do cuidado aos genitores e recém-nascidos prematuros, na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Objetivo da Pesquisa:

Compreender a vivência de genitores de recém-nascidos prematuros entre a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e a continuidade do cuidado em saúde em região de fronteira.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prpg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.532.108

No presente estudo, a entrevista semiestruturada visará compreender experiências de momentos de vulnerabilidade dos participantes, e sendo assim, conforme o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Viçosa (2020), os riscos de natureza emocional podem envolver: possibilidades de constrangimento ao responder o questionário, desconforto, medo, vergonha, estresse, quebra de sigilo, desgaste e quebra de anonimato. No TCLE complementa-se o manejo dos possíveis riscos, contemplando as normativas do CEP "Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita".

Benefícios:

A pesquisa pode beneficiar os participantes através da autopercepção e ressignificação dos relatos sobre as experiências vividas, assim como contribuir com o município e com a literatura de forma geral, buscando ofertar conhecimento científico que proporcione subsídios para criação de políticas de humanização no cuidado ao RNPT.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

não há.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os termos foram anexados e assinados em conformidade com requisitos do CEP

Recomendações:

não há.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

não há.

Considerações Finais a critério do CEP:

O pesquisador deverá entregar o relatório Final, assim que concluir o estudo. A desistência do estudo ou qualquer alteração ocorrida deverá ser comunicada, por emenda, apensada na Plataforma Brasil.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P	26/03/2025		Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.532.108

Básicas do Projeto	OJETO_2496648.pdf	09:53:57		Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	26/03/2025 09:48:12	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO.pdf	26/03/2025 09:46:23	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA.pdf	26/03/2025 09:44:55	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Outros	Anexo_IV.pdf	03/03/2025 19:17:50	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Outros	Anexo_III.pdf	03/03/2025 19:16:47	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_Rosto.pdf	09/02/2025 15:20:48	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Orçamento	ORCAMENTO1.pdf	06/02/2025 16:08:08	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Outros	INSTRUMENTO.pdf	06/02/2025 16:03:29	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Outros	Autorizacao_de_pesquisa.pdf	06/02/2025 16:02:09	ELYABE RODRIGUES	Aceito
Outros	SOLICITACAO_DO_CENNI.pdf	06/02/2025 16:00:47	ELYABE RODRIGUES	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCAVEL, 28 de Abril de 2025

Assinado por:

**Franciele Foschiera Camboin
(Coordenador(a))**

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Telefone: (45)3220-3092

Município: CASCAVEL

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br